LOOK WIDE

GUIDA PRATICA PER PROFESSIONISTI.

APPROFONDIRE LA TEMATICA DELLA VIOLENZA DI GENERE INTEGRANDO LA DIVERSITÀ DI GENERE E SESSUALE

Questa guida è finanziata dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020). Il contenuto di questa pubblicazione è di sola responsabilità degli autori e rappresenta unicamente i loro punti di vista.
La Commissione Europea declina ogni responsabilità d'uso delle informazioni contenute.

RINGRAZIAMENTI

La realizzazione di questa guida è stata possibile grazie alla collaborazione di numerose persone e organizzazioni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al progetto Look Wide negli ultimi due anni.

Un ringraziamento particolare va a:

Pam Alldred della Brunel University di Londra, **Suryia Nayak** dell'Università di Salford, **Jasna Magic** e **Peter Kelly** di Galop, **Laia Costa** del Consiglio comunale di Barcellona, **Roberta Mesiti** di Agedo Roma, **Irene Vlachou**, **Finn Lorenz**, **Eva Horvath** e alle associazioni **LesMigras Berlin** e **Arcilesbica Roma**.

COORDINAMENTO

Nagore García (Fundació Surt)

CONTENUTI

Gabriel Nox Kohnke e **Katharina Krämer** (Dissens)
Sabrina Frasca e **Chiara Spampinati** (Differenza Donna ONG)
Bea Sandor (Háttér)
Nancy Papathanasiou (KMOP)
Nagore García (Fundació Surt)

TRADUZIONE

Ludovica Pimpinella (Differenza Donna ONG)

GRAFICA E LAYOUT

Raffaella Varrone
Vanessa Doddi (Differenza Donna ONG)

LOOK WIDE

GUIDA PRATICA PER PROFESSIONISTI.

APPROFONDIRE LA TEMATICA DELLA VIOLENZA DI GENERE INTEGRANDO LA DIVERSITÀ DI GENERE E SESSUALE

Fundació Surt
SURT
DIFFERENZA DONNA
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA
dissens
HÁTTÉR SOCIETY
KMOP
KINDLING A BETTER WORLD

PREFAZIONE A CURA DI VĚRA JOUROVÁ

È necessaria un'azione costante per la protezione di tutte le persone colpite dalla violenza di genere, comprese le persone LGBTI

Immaginate di aver recentemente sperimentato un episodio di crimine d'odio fobico LGBTQIA+ o violenza da partner intimo in una relazione omosessuale o come persona trans, e quando vi rivolgete alle autorità o ai servizi di supporto di assistenza legale o psicologica per i sopravvissuti di violenza di genere, incontrate professionisti che dicono di aver mai parlato con una persona LGBTQIA+, ponendo domande inappropriate o non rispondendo alle esigenze più importanti. Molte persone LGBTQIA+ affrontano questa esperienza quotidianamente.

L'odio e la violenza, purtroppo, fanno parte della vita quotidiana delle persone LGBTQIA+ nell'UE.

Le ricerche dimostrano che si verificano negli spazi pubblici e comunitari (scuole, luoghi di lavoro, abitazioni e strade), ma anche nelle famiglie e nelle relazioni di intimità e persino nelle istituzioni pubbliche. La maggior parte delle violenze non sono mai segnalate al sistema giudiziario penale o alle organizzazioni della società civile che operano nei servizi di aiuto.

Le disposizioni legislative europee e nazionali conferiscono protezione contro ogni tipo di violenza e i servizi di supporto operano in ogni paese europeo.
C'è, tuttavia, molto lavoro da fare per garantire una protezione immediata, completa, reale ed efficace per le persone LGBTQIA+ vittime di violenza, nonché per garantire il loro diritto all'informazione sui servizi di supporto.

La Commissione segue da vicino l'attuazione della legislazione dell'UE sui diritti delle vittime di reato, tra cui i diritti che sono sanciti e che sono particolarmente rilevanti per le persone LGBTQIA+.

Anche il sostegno alle iniziative della società civile per contrastare l'omofobia e la transfobia rimane una delle nostre priorità di finanziamento, in quanto riteniamo che i progressi possano essere realizzati solo unendo gli sforzi e rafforzando e sostenendo i soggetti indipendenti, come le organizzazioni della società civile che promuovono e sostengono tale progresso e ne fanno una realtà sul campo.

Il progetto Look Wide, incentrato sullo sviluppo di servizi a sostegno alle persone LGBTQIA+ colpite dalla violenza di genere, che la Commissione ha cofinanziato come parte del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, è un buon esempio

di come il nostro impegno e il nostro quadro di riferimento per affrontare il crimine d'odio e garantire giustizia e sostegno alle persone colpite dalla violenza possa tradursi in orientamenti pratici e iniziative a beneficio delle persone colpite dalla violenza e dei responsabili politici.

La promozione e lo sviluppo di tali iniziative è più importante che mai.

Mi impegno a difendere e promuovere i nostri valori comuni di uguaglianza e di protezione contro i pregiudizi, i valori su cui si fonda l'Unione europea.

Věra Jourová

European Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality

1. PER COMINCIARE

1.1 • Introduzione

Questa guida è stata creata per i e le professioniste nell'ambito del progetto **LOOK WIDE: Sviluppare un metodo di lavoro a supporto delle persone LGBTQIA+ vittime di violenza di genere** integrando la diversità sessuale e di genere, finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (REC-VAW-AG-2016-01-776985).

Obiettivo del progetto è contribuire a garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e intersessuali vittime di violenza di genere (di seguito GBV) attraverso **l'integrazione della prospettiva di genere e di diversità sessuale nei servizi di supporto specializzati**.

Le persone LGBTQIA+ vittime di GBV nell'UE non ricevono un sostegno adeguato, ciò comporta una violazione dei loro diritti.

Gli Stati membri non hanno sviluppato sufficienti servizi di supporto per le persone vittime di GBV che tengano conto delle specificità delle realtà LGBTQIA+.

I servizi di supporto sono principalmente diretti a donne cis eterosessuali.
La diversità sessuale non viene inclusa nelle metodologie di lavoro delle case rifugio e dei servizi di consulenza psicologica, legale e di orientamento al lavoro e, di conseguenza, le persone LGBTQIA+ non si rivolgono a tali servizi; o, quando lo fanno, non ricevono un sostegno adeguato alle loro esigenze.

Alla luce di tale situazione, LOOK WIDE propone di approfondire la conoscenza del fenomeno della GBV nei confronti delle persone LGBTQIA+, nonché di identificare le sfide e le buone pratiche dei professionisti dei servizi specializzati;
sviluppare metodi di lavoro innovativi per sostenere le persone LGBTQIA+ vittime di GBV con un approccio basato sulla diversità sessuale e di genere;
formare i professionisti del contrasto alla discriminazione e alla GBV al fine di migliorare il sostegno alle persone LGBTQIA+;
sviluppare e sperimentare azioni di supporto, sensibilizzazione ed empowerment per le persone LGBTQIA+ e sensibilizzare professionisti, policy-maker e organizzazioni della società civile (OSC) sulla necessità di migliorare i servizi per le persone LGBTQIA+ vittime di GBV.

È stato possibile realizzare il progetto, grazie ad una proficua collaborazione tra cinque organizzazioni di diversi stati europei.

Differenza Donna ONG, è un'associazione con sede a Roma (Italia), fondata nel 1989 il cui obiettivo è quello di far emergere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere.

Dissens è un ente di ricerca, consulenza e formazione attivo a Berlino (Germania) dal 1989 che offre programmi di riflessione sul genere dedicati ai ragazzi, sulla diversità sessuale e di genere e sulla violenza sessuale.

Háttér Society è un'organizzazione LGBTQIA+ fondata a Budapest (Ungheria) nel 1995. Fornisce sostegno, conduce ricerche sui bisogni delle persone LGBTQIA+ e integra tali tematiche nella legislazione e nei servizi pubblici.

KMOP è un'organizzazione greca con sede ad Atene, fondata nel 1977 che lavora per sostenere i gruppi svantaggiati con interventi orientati alla soluzione e basati sulla conoscenza, cruciali per promuovere la resilienza.

Infine, **Fundació SURT,** è un'associazione di Barcellona (Catalogna) che dal 1993 lavora per garantire l'applicazione dei diritti economici, sociali e culturali delle donne e per eliminare ogni forma di discriminazione di genere.

Inoltre, LOOK WIDE deve molto alle reti di consulenza di tutti i paesi partner e di altri Stati membri (come la Polonia o il Regno Unito) che hanno riunito professionisti, esperti, policy-maker, rappresentanti del mondo accademico e delle OSC nel campo della GBV e non-discriminazione LGBTQIA+, che hanno contribuito, nelle diverse fasi del progetto, con le loro revisioni e suggerimenti.

Durante i due anni del progetto, sono state realizzate diverse attività per raggiungere gli obiettivi. Il progetto è iniziato con una breve fase di ricerca in cui ogni partner ha condotto una valutazione dei bisogni a seguito di interviste qualitative condotte da professionisti specializzati e rivolte a persone LGBTQIA+ colpite da GBV. Tale ricerca qualitativa ha prodotto un rapporto transnazionale le cui conclusioni principali sono riassunte nel Capitolo 2 di questa guida.

Dopo la ricerca, sono stati formati 140 professionisti nei diversi paesi.
La formazione è stata seguita dall'implementazione di programmi di supporto specifici per le persone LGBTQIA+ in situazioni di violenza.
A questo proposito, numerose organizzazioni dei vari paesi partner hanno ricevuto consulenza nella progettazione e nello sviluppo di azioni rivolte alle persone LGBTI nei loro centri e servizi.

Inoltre, si sono tenuti due seminari di scambio di conoscenze e competenze, a Berlino (luglio 2018) e a Roma (maggio 2019), ai quali hanno partecipato diversi/e esperti/e del settore.

1.2 • La guida

La guida LOOK WIDE è il risultato di un **processo collettivo di produzione di conoscenze** che ha avuto inizio fin dalle prime fasi del progetto.
Questa procedura ha cercato di approfondire le caratteristiche innovative della metodologia partecipativa LOOK WIDE. La guida è stata prodotta non solo dalla partnership, ma anche altre persone hanno contribuito in modi diversi.

È stato un viaggio impegnativo. La partnership LOOK WIDE è formata da organizzazioni molto diverse, provenienti da paesi con differenze sostanziali in relazione al quadro giuridico-normativo e ai servizi di supporto in materia di GBV e LGBTQIA+. Ciascun partner ha affrontato forme specifiche di violenza (ad esempio Hátter si è concentrato sui sistemi di supporto per le vittime di bullismo LGBTQIA+fobico), con scopi diversi (ad es. Surt ha incorporato diverse sfere in cui la violenza può verificarsi, dal livello interpersonale delle relazioni intime al livello istituzionale del sistema sanitario o alla discriminazione legale). Questa guida intende mostrare e far riflettere circa questa eterogeneità come aspetto positivo.

Anche i quadri concettuali e la terminologia erano diversi e talvolta contraddittori. Per esempio, alcuni partner usano il termine LGBTI, mentre altri preferiscono il termine più inclusivo LGBTIQ+ o LGBTIQA, che riconosce e mette in luce identità sessuali e di genere che vanno oltre le norme sociali di genere e sessualità.
All'inizio del progetto "LGBTI" è stato utilizzato come termine riconosciuto all'interno della politica europea, tuttavia il lavoro di collaborazione di LOOK WIDE, **ha portato all'uso dell'acronimo più inclusivo LGBTQIA+**.
In questa guida, LGBTQIA+ sarà utilizzato per includere sesso, genere e non-normatività sessuali meno visibili.

Sono emersi anche dibattiti circa l'uso dei termini vittima/sopravvissuto/a.
Il termine vittima pone l'accento sull'autore del reato e sembra essere più efficace in ambito giuridico. Tuttavia, come termine sociale, vittima è molto problematico, in quanto produce una seconda vittimizzazione, ignorando l'agito delle persone. Per questo motivo, sopravvissuto/a è proposto solitamente come un'alternativa più rafforzante, che si concentra sulla capacità di reagire degli individui. Ciononostante, il termine sopravvissuto/a può essere visto come troppo individualista e segna una temporalità in cui la violenza è definita come un atto precedente e già superato. In numerosi paesi, i professionisti e i servizi stanno esplorando altre definizioni, come ad esempio "persone in situazioni di violenza" (abbastanza diffuso in Catalogna) o "con un vissuto di violenza" (traduzione letterale dal tedesco). In realtà, come appreso durante il progetto, le rappresentazioni binarie di vittima/sopravvissuto/a sono radicate e ricreano visioni semplicistiche del genere, che hanno effetti dannosi sulle persone. Per evitare la

rivittimizzazione e la semplificazione dei ruoli di genere, sarà pertanto utilizzato il termine “persone colpite dalla violenza”.

La guida si rivolge ai/le professionisti/e dei servizi specializzati nel contrasto alla GBV e alla discriminazione, agli esperti nel supporto alle persone LGBTQIA+, ma può essere utile anche ad altri professionisti (come operatori sociali o sanitari), che forniscono servizi anche alle persone LGBTQIA+.

La guida è suddivisa in capitoli, completati alla fine da diversi allegati.
Tali materiali includono attività che possono essere realizzate durante la formazione con i professionisti o come esercitazioni individuali di auto-formazione e buone pratiche organizzative, utili per integrare la diversità sessuale e di genere nell’attività di supporto alle persone colpite da GBV.
Ogni tipo di attività è evidenziato da un’icona specifica.

- Il capitolo 2 sintetizza **i principali risultati della ricerca** svolta nell’ambito del progetto: l’invisibilità delle persone LGBTQIA+ nei contesti giuridici e politici; i luoghi comuni sulla GBV; la necessità di un approccio alla violenza complesso e intersezionale; la sfida di strutturare un approccio basato sulla diversità sessuale e di genere nei servizi a contrasto della GBV.
- Il capitolo 3 è diviso in due sezioni. Il primo descrive la **proposta teorica** di LOOK WIDE di integrare nell’approccio alla GBV la diversità sessuale e di genere. La seconda sezione, relativa al **quadro giuridico**, sintetizza le leggi europee in materia di GBV e violenza contro le persone LGBTQIA+.
- Il capitolo 4 affronta diversi ambiti e tipi di **violenza contro le persone LGBTQIA+**, nonché il loro impatto, inclusa la violenza nelle relazioni intime e le microaggressioni e gli effetti sulle persone con sessualità e identità di genere non normate.
- Il capitolo 5 descrive il profilo delle competenze dei professionisti che lavorano nei servizi specializzati a contrasto della GBV. Contiene delle **raccomandazioni per le diverse fasi nell’intervento contro la GBV**: prevenzione, individuazione, supporto e recupero.
- Il capitolo 6 illustra i principi generali per un **intervento multi-agenzia coordinato tra più enti** in questo settore.

  Infine, la guida termina con le **Conclusioni**, che sottolineano la necessità di continuare a lavorare e forniscono raccomandazioni per i **policy-maker**.

BOX 1: • GLOSSARIO

Allosessuale:
una persona allosessuale prova attrazione sessuale verso altre persone, ad es. eterosessuale, omosessuale, pansessuale o altro.

Aromantico, non romantico:
una persona che non ha esperienza di attrazione romantica per altri e/ o interesse per le relazioni romantiche. Non è necessariamente legato all'asessualità.

Asessuale:
una persona che non prova o prova minima attrazione sessuale per altre persone. Poiché l'asessualità è una tendenza, è possibile trovarlo scritto nelle forme a-sessuale o a*sessuale. Non ha a che vedere con l'astinenza sessuale o il rifiuto del sesso. L'astinenza è una libera decisione mentre l'asessualità è un orientamento sessuale, e tuttavia le persone asessuate possono decidere di fare sesso per vari motivi. Non è necessariamente legato all'aromanticismo.

Afobia:
si riferisce alla discriminazione contro le persone asessuate e aromantiche e si manifesta con rifiuto, rabbia, intolleranza, pregiudizio, disagio o violenza fisica o psicologica contro le persone asessuali/aromantiche o le persone che sono percepite come tali.

Bisessuale/Pansessuale:
quando una persona si identifica come emotivamente e/o sessualmente attratta da più di un sesso.

Cis:
è un termine per indicare chi rimane attivamente o passivamente entro le norme sociali del genere assegnato alla nascita.

Fare coming out:
il processo di comprensione, accettazione, e rivelazione della propria identificazione come lesbica, gay, bisessuale, trans, o persona intersessuale. Il concetto stesso è costruito sull'eterosessualità, cisessualità e normatività binaria di genere, come se coloro che non sono eterosessuali e / o cis debbano rivelarlo agli altri. Fare coming out non avviene una tantum, infatti le persone LGBTI decidono di/sono costrette a farlo più volte durante la loro vita con persone diverse, per es. colleghi, nuovi amici, vicini di casa, medici, ecc.

Discriminazione:
il processo di divisione e gerarchizzazione all'interno dei gruppi sociali che crea disuguaglianza. Di conseguenza, i gruppi che si trovano in cima ottengono una posizione privilegiata, mentre quelli che si trovano al di sotto vengono discriminati. Se il potere viene esercitato dall'alto verso il basso (cosa che può avvenire individualmente, ma anche istituzionalmente e strutturalmente), allora avviene una discriminazione. Esempi di forme di discriminazione sono:

Discriminazione diretta:
quando una persona è trattata meno favorevolmente da altre persone.

Discriminazione indiretta:
quando una regola o una pratica apparentemente neutra pone una persona in una posizione di svantaggio rispetto ad un'altra.

Discriminazione multipla:
discriminazione basata su più aspetti.

Discriminazione sperimentata:
chiamata anche discriminazione soggettiva, esperienza di discriminazione.

Gay:
un uomo cis o trans che si identifica come attratto sessualmente e/o emotivamente dagli uomini. A volte 'gay' è utilizzato anche come termine generico per parlare delle donne lesbiche e delle persone bisessuali. Tuttavia, questo uso è stato contestato da gran parte della comunità LGBTI, pertanto, in questa guida, 'gay' è utilizzato per riferirsi strettamente a uomini cis o transessuali che si identificano come emotivamente e/o sessualmente attratti dagli uomini.

Genere:
si riferisce alla costruzione sociale che assegna determinati comportamenti ai ruoli maschili e femminili. Anche se il genere può essere interiorizzato ed è ora riconosciuto da molti come separato dal sesso biologico, da un punto di vista storico non è mai stata una decisione individuale, ma piuttosto un'identità prescritta basata sul sesso assegnato alla nascita. La base di tale costruzione è una categorizzazione marcatamente gerarchica in cui i ruoli e le caratteristiche collegati al potere sono normalmente correlati e associati al genere maschile.

Espressione di genere:
l'espressione di genere è il modo in cui le persone rappresentano il proprio genere, ad esempio attraverso taglio di capelli, abbigliamento, o comportamento. Alcune persone rappresentano maschi, altre femmine, altre rappresentano entrambi allo stesso tempo o non vogliono essere visti come maschi né femmine. Ciò può essere, ma non necessariamente, legato al sesso assegnato alle persone alla nascita, al genere o all'identità di genere.

Identità di genere:
si riferisce all'esperienza personale e individuale del genere di ogni persona, che può o non può corrispondere al sesso assegnato alla nascita.

Non conformità di genere / non conformismo di genere:
riguarda il non conformarsi alle norme di genere / aspettative di genere di una data cultura. "Non conformità di genere" è usato per definire un'espressione di genere non corrispondente ai ruoli di genere prescritti dalla società o alle norme di genere. La non conformità di genere trasgredisce le aspettative sociali o psicologiche che sono assegnate a quel genere per come viene percepito dalle norme, attraverso la presentazione, il comportamento, l'identità o altri mezzi.

LGBT fobia:
ostilità generale, psicologica e sociale rivolta alle persone LGBTI. Costruzione sociale che promuove l'eterosessualità come unica sessualità accettata e la creazione di una gerarchia delle sessualità. Per molti/e autori/trici femministi/e, la radice dell'omo-lesbo-trans-bi-inter-fobia è il sessismo che

controlla la sessualità e sopprime ogni comportamento che supera i confini tra i sessi. Anche se in questo senso omofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia fanno parte dello stesso fenomeno, è importante distinguerli perché hanno manifestazioni e intensità diverse.

Intersezionalità:
approccio femminista che sottolinea l'intreccio di vari sistemi di oppressione e diverse categorie sociali come genere, etnia, classe o orientamento sessuale, che generano disuguaglianza. L'obiettivo delle prospettive intersezionali è analizzare l'interazione delle diverse posizioni di disuguaglianza sociale e dimostrare che le forme di oppressione non possono essere sommate come un tutt'uno, ma vanno considerate nei loro intrecci e interazioni. Questa prospettiva permette di analizzare molteplici relazioni di disuguaglianza e oppressione che non possono essere spiegate dalla sola categoria di genere.

Intersessuale:
termine che si riferisce a una serie di tratti fisici o variazioni che si trovano tra le rappresentazioni stereotipate del maschio e della femmina. Le persone intersesessuali nascono con caratteristiche fisiche, ormonali o genetiche che non sono né interamente femminili né interamente maschili; o una combinazione di maschio e femmina; oppure né femminili né maschili. Esistono molte forme di intersessuale; la parola è infatti un termine ombrello, non rappresenta una unica categoria.

Inter:
un termine sviluppato dalla comunità che descrive la varietà delle realtà e fisicità inter come termine ombrello emancipatore e identitario. Inter è usato come termine ombrello per intersessuali, intersex, intergender e inter- o persone intersessuali che nascono con un corpo che non corrisponde alle norme e agli standard sessuali tipici di uomo e donna. L'intersessualità è utilizzata come diagnosi patologica per queste persone, perché le loro caratteristiche fisiche non possono essere inequivocabilmente attribuite al sesso maschile o femminile. Pertanto, molte persone inter* rifiutano questo termine come auto-descrittivo.

Interfobia:
descrive la paura dell'esistenza e dell'espressione delle persone intersesessuali, nonché della diversità fisica e di genere. Ciò porta alla violenza, alla discriminazione, all'esclusione e all'impossibilità medica, sociale e giuridica delle identità e fisicità inter* (rafforzata da interventi chirurgici che vengono spesso eseguiti, ma non sempre), in tenera età. L'interfobia banalizza la violenza derivante dall'annientamento inter*.

Lesbica:
una donna cis o trans che si identifica come attratta sessualmente e / o emotivamente dalle donne.

LGBTI:
acronimo per lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali. Un gruppo eterogeneo spesso trattato insieme nel dibattito sociale e politico. Secondo gli

attivisti questo acronimo è esclusivo, in quanto lascia fuori le persone queer, asessuate e aromantiche. Motivo per cui vengono proposti LGBTIQA o LGBT+ o altri acronimi simili.

Queer:

questa parola ha assunto molti significati. Originariamente "queer" era un termine offensivo – che significava diverso o strano – successivamente rivendicato come una parola positiva. Implica anche una posizione politica in opposizione alle strutture eteronormative dominanti e alle convenzionali politiche d'identità LGBT. È un termine ombrello per coloro che sfidano le norme di genere e sessualità, ma anche le convenzioni LGBTI e altre norme sociali, come ad esempio il lookismo, la discriminazione basata sull'aspetto fisico.

Sesso:

si riferisce alla composizione biologica, le caratteristiche sessuali interne ed esterne corporee quali genitali e gonadi (cioè testicoli, ovaie), geni e ormoni. Il sesso legale viene solitamente assegnato alla nascita ed è stato tradizionalmente inteso come composto da due gruppi reciprocamente esclusivi: maschio e femmina. Tuttavia, questa classificazione biologica può essere messa in discussione e il sesso assegnato alla nascita potrebbe non corrispondere all'identità di genere di una persona.

Orientamento sessuale:

Si riferisce alla capacità di ogni persona di provare profondo affetto, e/o attrazione emotiva e sessuale verso, e/o instaurare relazioni intime e sessuali con, individui di un diverso genere o dello stesso genere o più di un genere.

Persone trans:

Le persone trans sono persone con un'identità di genere diversa dal genere assegnato alla nascita. Le persone trans possono o meno esprimere il proprio genere attraverso la scelta di abiti, modifiche del corpo (che possono includere interventi chirurgici) o altre manifestazioni di genere. La parola "trans" è spesso usata come categoria ombrello che comprende tutte le identità e le espressioni di genere non normative. Potremmo dire che esistono tanti modi di vivere l'identità trans quante sono le persone trans. Allo stesso modo, possiamo trovare tanti modi di vivere la mascolinità e la femminilità quanti sono gli uomini e le donne nel mondo.

Non-binario:

Un termine generico per molte identità di genere che si trovano al di fuori del binario uomo-donna, come per es. le persone agender (che non si identificano in alcun genere) o genderfluid (con un'identità di genere continuamente in cambiamento). Alcune persone non binarie si identificano come trans e altre no.

Rivittimizzazione o vittimizzazione secondaria:

È un tipo di violenza istituzionale perpetrata da operatori statali o fornitori di servizi sociali. È una reazione sociale negativa conseguente alla vittimizzazione primaria ed è vissuta come ulteriore violazione di diritti legittimi.

Ulteriori informazioni e risorse

- **Sito web di LOOK WIDE:**
  http://lookwideproject.eu/
- **Rapporto transnazionale:**
  http://lookwideproject.eu/sites/default/files/2019-03/Look%20Wide%20Comparative%20Report.pdf
- **Differenza Donna ONG**
  https://www.differenzadonna.org/en/differenza-donna-home-eng/
- **Dissens**
  https://www.dissens.de/
- **Háttér Society**
  http://en.hatter.hu/
- **KMOP**
  https://www.kmop.gr/
- **Fundació SURT**
  http://ww.surt.org/en/

2. IMPARARE DAL RAPPORTO TRANSNAZIONALE: aspetti comuni e sfide per l'integrazione di un approccio di genere e diversità sessuale

2.1 • Conclusioni principali

Durante la fase di ricerca del progetto ciascun partner ha realizzato una valutazione nazionale dei bisogni delle persone LGBTQIA+ colpite dalla violenza e dei professionisti dei servizi di supporto specializzati. Tuttavia, sono emerse alcune differenze nell'approccio di ciascun partner che meritano di essere menzionate. KMOP e SURT si sono concentrati su una versione più ampia della violenza, sugli adulti LGTBIAQ+ e sui professionisti specializzati nel supporto alle persone LGBTIAQ+ colpite dalla GBV. Sebbene Dissens affronti molte forme di GBV, nelle consulenze alle persone LGTBIAQ+ si è orientato soprattutto sull'approccio peer to peer e community based, prevalenti in Germania. D'altro canto, Hátter si è concentrato sulla prevenzione e il contrasto al bullismo LGBTIAQ+ fobico nelle scuole, mentre Differenza Donna ha affrontato la violenza tra partner nelle coppie lesbiche. Sono stati intervistati complessivamente 52 professionisti e 29 persone LGBTIAQ+.

Da queste valutazioni dei bisogni è stato realizzato un rapporto comparativo transnazionale. Il rapporto analizza i quadri giuridici esistenti di ciascun paese e i dati qualitativi raccolti dalle 81 interviste approfondite con professionisti e persone LGBTIAQ+. Nonostante queste differenze e le specificità di ciascun contesto e di ogni tipo di violenza, le interviste hanno portato a conclusioni simili, riassunte in questo capitolo.

Uno dei principali assunti emersi dalla ricerca è la necessità di un approccio più ampio e intersezionale su molti livelli diversi (pratiche di consulenza, sensibilizzazione, legiferazione, politiche ecc.) del sistema di supporto, al fine di fotografare pienamente la realtà e la natura dei problemi che le persone LGBTIAQ+ devono affrontare. Le complessità della discriminazione devono essere prese in seria considerazione e la GBV non dovrebbe essere limitata alla violenza maschile contro le donne (come emerge dalla stessa definizione della Convenzione di Istanbul, ad esempio, senza tenere conto della definizione di "donne").

È emerso chiaramente che sebbene ci siano molte persone che lavorano duramente per garantire servizi di qualità a chi ha bisogno di supporto, c'è ancora tanto lavoro da fare. I professionisti hanno bisogno di una formazione continua(ad esempio, riflettendo sul proprio lavoro, acquisendo maggiori conoscenze, lavorando a livello intersezionale), le leggi devono essere migliorate e ampliate

(ad esempio per una definizione più ampia di GBV e leggi di protezione più concrete) e sono necessari più servizi (più risorse fornite dai contesti nazionali).

2.2 • L'invisibilità delle persone LGBTQIA+ a livello giuridico

La GBV è per lo più concettualizzata come violenza maschile contro le donne. Le "donne", le quali come gruppo non specificato rispetto ad altre categorie sono centrali, rendono invisibili forme più complesse di discriminazione. La definizione piuttosto ristretta di GBV alla base di molte leggi, impedisce alle persone LGBTIAQ+ di avvalersi di leggi a tutela. I diritti LGBTIAQ+ devono operare in tutta l'UE, affinché le persone LGBTQIA+ siano adeguatamente tutelate in tutti i paesi. Di conseguenza, è necessario rendere applicabile uno spettro ampio ed esplicito di diverse forme di GBV: questa deve essere ben definita, in modo da renderne visibili il maggior numero possibile di forme, affinché le persone colpite dalla violenza sappiano di avere il diritto di chiedere aiuto ed essere tutelate dalla legge. È anche importante sottolineare che LOOK WIDE non si concentra solo sulla violenza interpersonale, ma anche su forme di violenza diverse e più ampie, ad esempio:

- **Violenza strutturale**, come sessismo, razzismo, omofobia, transfobia, classismo, ecc.
- **Violenza istituzionale** attraverso leggi, sistema sanitario, polizia e autorità, ecc
- **Violenza interpersonale** come nelle relazioni intime, molestie pubbliche, violenza fisica, ecc.

Per diventare visibili, tutte queste forme di violenza devono essere riconosciute a livello legale e conosciute a livello professionale.

La nostra ricerca mostra che gran parte del lavoro contro la GBV nei confronti delle persone LGBTIAQ+ è volontario e non retribuito: prova della sostanziale necessità di risorse e riconoscimento. Le risorse sono essenziali per garantire un lavoro di qualità e un maggiore impatto sulla società. Inoltre, i servizi di consulenza spesso non sono formati professionalmente in materia legale.

In generale, l'invisibilità LGBTIAQ+ a livello giuridico si traduce in un'invisibilità delle persone LGBTIAQ+ all'interno dei servizi tradizionali a contrasto della GBV. Se prendiamo ad esempio la legislazione spagnola, le leggi contro la GBV non includono in alcun modo le persone LGBTIAQ+, poiché si concentrano solo sulle donne eterosessuali in quanto persone colpite dalla violenza e sugli uomini

eterosessuali come persone che perpetrano la violenza. I servizi derivanti da questo tipo di legislazione non saranno automaticamente a conoscenza delle problematiche LGBTQIA+, né tanto meno saranno in grado di supportare adeguatamente le persone con storie di abusi e violenza su più livelli che non rientrano nel suddetto schema.

2.3 • Luoghi comuni sulla GBV: inclusione e esclusività

Molto spesso, le realtà specifiche delle persone LGBTQIA+ non rientrano nell'orizzonte dei servizi disponibili, ciò può limitarne l'accesso, soprattutto se si ha esperienza di servizi che non sono in grado di fornire supporto. A volte, i servizi no individuano la GBV correttamente o non la individuano affatto, oppure non rappresentano le identità delle persone o i loro problemi. Non avere chiaro il concetto di violenza o avere una scarsa comprensione della GBV potrebbe suggerire ad alcune persone che i loro problemi non sono nello spettro di determinati servizi e pertanto non saranno in grado di ottenere una consulenza adeguata. La mancata conoscenza delle problematiche LGBTQIA+ può, in ultima analisi, portare a servizi che escludono attivamente le persone LGBTQIA+, ad esempio attraverso il misgendering, o dando per scontato l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere delle persone, ecc.

Ciò riguarda soprattutto le persone che subiscono discriminazioni multiple, poiché (come ad esempio rileva il rapporto nazionale spagnolo) i tradizionali servizi a contrasto della GBV sono principalmente progettati per un tipo molto specifico di vittima (donna bianca, eterosessuale, sposata o con una relazione stabile), mentre le persone (LGBTQIA+) con questioni/problemi diversi e più complessi potrebbero essere lasciate indietro (ad esempio donne trans che vivono in strada/sex worker, donne che fanno uso di droghe, persone colpite da razzismo).
Anche raggiungere i/le giovani è una questione importante (rispetto all'intersezionalità). In tutti questi casi, non è sufficiente ampliare la definizione di violenza o vittima a livello teorico. L'inclusione deve essere una pratica largamente consolidata per essere efficace. Le interviste hanno dimostrato che spesso le persone LGBTQIA+ devono educare i servizi a cui accedono, il che può essere stressante e frustrante e può portare infine a non accedere più ad alcun servizio, così da evitare questa barriera aggiuntiva.
È importante notare che essere teoricamente aperti a gruppi di persone emarginate non è lo stesso che essere specificamente progettati per soddisfarne le esigenze. Infatti, una scoperta determinante della nostra ricerca è l'esigenza di implementare corsi di formazione o di professionisti consapevoli della reale situazione (ad esempio attraverso guide come questa, v. il capitolo 5 sulle raccomandazioni per i professionisti).

2.4 • Approccio intersezionale: dove andare, partendo da qui

Ogni persona rappresentata dall'acronimo LGBTQIA+ ha esigenze diverse e deve affrontare problemi specifici oppure, naturalmente, può appartenere a più di una di queste lettere (o a lettere che non sono comprese nell'acronimo). Inoltre, gli approcci intersezionali hanno lungamente illustrato come le discriminazioni si intrecciano: oltre a sessismo, omofobia, transfobia ecc., le persone LGBTQIA+ affrontano razzismo, discriminazione verso la disabilità, classismo e tutti i tipi di violenza strutturale.

In genere, è necessario riconoscere più tipi di violenza come, ad esempio: violenza strutturale, istituzionale, interpersonale, psicologica e quotidiana, nonché complessità intersezionali, microaggressioni, molestie in luoghi pubblici, ecc.

Le microaggressioni soprattutto, vengono spesso sottovalutate anche dai professionisti (anche se sono state ampiamente studiate e i loro effetti negativi sulle persone sono verificati scientificamente) quando si tratta di aiutare le persone ad affrontare la discriminazione. Tutti i problemi quotidiani, anche le più piccole cose combinate tra loro, possono gravare sulla psiche delle persone più di quanto sia comunemente riconosciuto. Anche la violenza strutturale è poco rappresentata, specialmente nelle legislazioni: la discriminazione è talmente alla base delle pratiche comuni che può passare inosservata anche alle persone colpite dalla violenza. Il capitolo 4, che affronta la violenza contro le persone LGBTQIA+, approfondirà questo aspetto.

Nominare la violenza strutturale come il "sistema etero-cis-patriarcale" e includere altre categorie come supremazia bianca, discriminazione contro la disabilità, discriminazione contro gli anziani, ecc. è utile per comprendere i problemi che le persone LGBTQIA+ affrontano. Avere definizioni concrete di violenza può essere importante per il lavoro e l'estensione dei servizi, poiché alcune forme di violenza non vengono riconosciute come tali.

Questi problemi di riconoscimento sintetizzano una comprensione insufficiente dell'intersezionalità da parte dei servizi, poiché la GBV si esprime in modo diverso a seconda della posizione sociale della persona che necessita supporto. Un esempio della ricerca tedesca illustra la rigidità dei servizi quando questi si concentrano solo su una categoria: un esperto ha riferito di una persona transgender di colore la quale, durante la transizione, è stata anche colpita da razzismo. Tuttavia, anche se durante i colloqui realizzati per la fuoriuscita dalla GBV se ne sia parlato, i servizi, che non vedono quanto le due problematiche di discriminazione siano intrecciate tra loro hanno consigliato di discuterne presso altre sedi in quanto questione antirazzista.

In generale, concetti come empowerment, approcci peer-to-peer, depatologizzazione e accessibilità sono fattori fondamentali per costruire i successivi passi concreti per il miglioramento, su diversi livelli. Le persone colpite da GBV che hanno bisogno di consulenza devono essere considerate come esperte della propria realtà e soprattutto prese sul serio. A tal proposito, la ricerca tedesca conclude che la depatologizzazione e l'impiego di persone che hanno avuto simili esperienze di violenza (consulenza peer-to-peer), possono essere un possibile punto di partenza per il cambiamento.

Tutti questi argomenti possono essere riassunti in domande concrete, che possono rappresentare un punto di partenza quando si tratta di scoprire come è impostato un servizio:

- I siti web a chi si rivolgono esplicitamente?
- In quali problematiche il consulente ha dimestichezza?
- In che modo il quadro giuridico modella i servizi?
- In che modo i settori di competenza e anche le identità dei consulenti influenzano il processo di consulenza (ad es. una consulenza realizzata tra due persone LGBTQIA+, approccio peer-to-peer)?

Per concludere questo capitolo, ecco alcune frasi chiave attorno alle quali ruota la valutazione dei bisogni nel Rapporto transnazionale:

- Abbiamo bisogno di più leggi, affidabili e migliori da attuare in tutti i paesi, assicurandoci che queste non rimangano teoriche ma siano applicabili, al fine di aiutare tutte le persone colpite da GBV.
- Le definizioni di violenza devono essere ampliate e rese esplicite e visibili, sia a livello teorico che pratico.
- I professionisti hanno bisogno di una formazione continua per essere preparati anche a livello pratico al lavoro sociale, con conoscenze più ampie e dettagliate.

Speriamo che questa guida sia uno strumento utile per progredire su queste tematiche.

INTERSEZIONALITÀ

La questione dell'intersezionalità, che indica sostanzialmente l'intreccio di diverse forme di discriminazione, non sembra essere ancora molto "popolare" nella pratica dei servizi sociali. Tutto sommato, solo singoli servizi antidiscriminazione specifici partono da un'analisi della discriminazione per contrastare la violenza.

L'assistenza sociale che opera nel settore antiviolenza, considera generalmente il sessismo e la misoginia come cause della violenza che gli uomini cis infliggono alle donne cis.

Il progetto LOOK WIDE mirava ad ampliare il concetto che i servizi anti-violenza hanno della violenza di genere (GBV), al fine di includere anche le realtà delle persone LGBTQIA+.

La violenza sulla base del comportamento omo-, trans-, inter-, bi- e a-fobico è un tipo di violenza fondata su rigidi costrutti sociali di genere e sessualità.

Nella fase di ricerca del progetto LOOK WIDE, tuttavia, è emerso che le persone LGBTQIA+ che hanno segnalato casi di discriminazione ai servizi di supporto, si sono ritrovate, nella maggior parte dei casi, in una complessa rete di discriminazioni, tra cui disabilità, classe, "razza"/" etnia", migrazione, religione, età, ecc. In particolare, una persona di colore potrebbe, ad esempio, sperimentare forme più gravi di razzismo quando viene percepita come queer. In questi casi, i servizi antiviolenza dedicati al contrasto della GBV potrebbero inviare la persona ad un'organizzazione anti-razzista, che a sua volta potrebbe indirizzarla ad un servizio specifico per persone queer. Oppure, una persona in cerca di aiuto potrebbe subire discriminazioni perfino nel medesimo posto in cui è venuta a cercare supporto.

Questi casi sono stati riscontrati con una tale frequenza da rendere evidente il fatto che i servizi antiviolenza devono essere formati sulle molteplici forme di discriminazione, nonché sul concetto di intersezionalità per essere più inclusivi e accoglienti verso più gruppi di persone e problemi più complessi. Non esistono, ad esempio, rifugi per senzatetto accessibili ed inclusivi delle persone LGBTQIA+, il che porta le persone a dormire per strada a causa di questo specifico problema di discriminazione. In linea generale, intersezionalità significa anche svelare le strutture che si celano dietro i singoli casi di discriminazione, e non affrontarli come casi individuali.

La maggior parte dei servizi antiviolenza si concentra principalmente sulle donne, pertanto il genere è l'unico asse di oppressione preso in considerazione. Nel progetto LOOK WIDE, grazie a una più ampia comprensione della GBV, che coinvolge anche le persone LGBTQIA+, abbiamo capito che l'ambito deve essere ulteriormente ampliato. Limitare la prospettiva al genere e alla sessualità rende invisibili altre dimensioni della condizione umana, ad es. essere poveri, neri, disabili, giovani, anziani ...

Le persone e le loro interazioni sociali sono molto più complesse del proprio genere e della propria sessualità. I servizi non sono preparati a un tale tasso di complessità, ed è proprio da ciò che nasce la necessità di integrare un approccio intersezionale, comprendendo che quando si incontrano diverse forme di discriminazione, sorge qualcosa di nuovo.
Quelle forme di oppressione e svantaggio non possono essere semplicemente sommate, ma devono essere considerate nei loro intrecci e interazioni come una fitta rete di dinamiche sociali. La prospettiva intersezionale consente di analizzare molteplici relazioni di disuguaglianza e oppressione che non possono essere spiegate da una sola categoria (ad esempio quando il sessismo e il razzismo si incontrano, il fenomeno non può essere spiegato e compreso in modo soddisfacente analizzando unicamente il sessismo o il razzismo). Questa prospettiva impedisce inoltre di ritrarre le persone LGBTQIA+ come privilegiate (bianchi, di classe media, normodotati, ecc.).
Molti, tra i servizi che abbiamo intervistato, hanno affermato che considerano quello intersezionale l'approccio migliore, anche se ogni organizzazione si trova in una fase diversa dell'implementazione effettiva di tale approccio. Quanto più una persona viene discriminata, tanto più aumenta il rischio che sia esposta alla violenza. Allo stesso modo, diminuisce la probabilità di trovare un adeguato supporto. Questo avviene perché se il servizio è sensibile ad una sola forma di discriminazione, potrebbe discriminare altre caratteristiche della persona, oppure non comprendere (pienamente) come agiscono le discriminazioni multiple e quali effetti producono.

In conclusione, l'intersezionalità è importante perché la violenza contro le persone LGBTQIA+ potrebbe emergere come discriminazione razzista, classista e/o verso la disabilità e viceversa: la complessità delle diverse forme di oppressione e privilegi dovrebbe essere sempre integrata (superandone l'uso di "elegante termine in voga", come affermato da alcuni professionisti intervistati).

PER INIZIARE UN REALE PENSIERO INTERSEZIONALE, ECCO ALCUNE DOMANDE RIFLESSIVE:

- *Il servizio adotta una visione femminista decoloniale? C'è consapevolezza dell'euro-centrismo?*
- *È richiesta una formazione in competenze interculturali o campi simili?*
- *Quali sono le tematiche a cui il servizio è sensibile? A quali non lo è? (ad es. razzismo, d, classismo, discriminazione nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità ecc.)?*
- *Esistono linee guida per lavorare con gruppi specifici di persone (ad es. giovani LGBTQIA+, senzatetto, migranti provenienti da specifici paesi, ecc.)?*
- *Per quali gruppi di persone il servizio vuole intervenire? E rispetto a questo: chi vi si rivolge? Ci sono gruppi che non vi si rivolgono mai? Potrebbero esserci barriere invisibili che tengono lontane alcune persone. Applicare l'intersezionalità può ridurle.*
- *All'interno dello staff sono rappresentate identità diverse in termini di background etnico (disabili/normodotati, identità di genere, età varia, ecc.)?*

3. I QUADRI CONCETTUALI E GIURIDICI

3.1 • Approccio al genere e alla diversità sessuale nella GBV

La Direttiva sui Diritti delle Vittime (2012/29/UE) definisce la GBV come "una violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere". Nonostante questo obbligo gli Stati membri non hanno sviluppato servizi di supporto sufficienti per le persone colpite da GBV che tengano conto delle specificità delle vittime LGBTQIA+.

Da un lato, i servizi di supporto alla GBV nelle sue diverse forme (violenza da partner o violenza sessuale, ad esempio) sono principalmente diretti alle donne eterosessuali cis vittime di uomini cis. La diversità sessuale non è integrata e, di conseguenza, le persone LGBTQIA+ non si rivolgono a questi servizi o, se lo fanno, non ricevono servizi adeguati alle loro esigenze.

D'altro canto, laddove esistono servizi pubblici o ONG anti-discriminazione, questi forniscono supporto in situazioni di omofobia e transfobia, ma non integrano un approccio di genere ponendo l'accento solo sui pregiudizi contro la diversità sessuale.

In questo contesto, Look Wide mira ad ampliare l'approccio alla GBV integrando una prospettiva di genere e di diversità sessuale. L'idea principale è che tanto la violenza contro le donne quanto la violenza contro le persone LGBTQIA+ siano manifestazioni diverse di GBV, che hanno proprie specificità, ma che condividono la stessa radice, il sistema eteropatriarcale. Tuttavia, come evidenziato nella ricerca condotta all'inizio di questo progetto, questa articolazione concettuale non è così ovvia.

I quadri concettuali di genere e sessualità che sono riprodotti nelle politiche pubbliche - e che guidano i modelli di intervento dei servizi - tendono ad essere un'unica questione, cioè si concentrano su un aspetto, sia esso il genere o la sessualità, senza considerare come questi si relazionano tra loro o altre disuguaglianze (Coll-Planas & Cruells, 2013). Come risultato di questo unico approccio, a livello professionale, i servizi di supporto non riescono a integrare una prospettiva di genere o femminista – che evidenzia le disuguglianze strutturali tra uomini e donne – mentre i tradizionali servizi a contrasto della GBV mancano di una prospettiva di diversità sessuale o affrontano grandi difficoltà nel tentativo di incorporarla. In questo senso, l'impegno di Look Wide nell'articolazione di un approccio di genere femminista e di diversità sessuale ha evidenziato la necessità di ripensare i modelli di lavoro sociale nell'individuazione, supporto e reinserimento

delle persone colpite da GBV. Questa esperienza sottolinea come, invece di aggiungere le persone LGBTQIA+ ai tradizionali contesti esistenti dei servizi di contrasto alla GBV - principalmente rivolti a donne eterosessuali adulte in relazione con un autore di violenza maschile - sia necessario un processo di riflessione critica su questi servizi.

3.2 • Il genere come violenza

Look Wide propone un quadro in cui il genere stesso è inteso come violenza nella misura in cui definisce i modi corretti e possibili di essere nel mondo. Attraverso il genere, ci viene detto cosa ci si aspetta da noi, quali sono i nostri limiti di azione, quale rapporto possiamo stabilire o meno. Cioè, siamo costretti ad assumere ruoli, atteggiamenti e comportamenti stereotipati, disuguali e discriminatori e che si definisce all'interno di un sistema binario in cui esistono solo due modi possibili di abitare il mondo: essere uomo o donna. Come risultato di questo sistema normativo di genere, le persone che non si conformano o che resistono a queste norme vengono punite socialmente ed è per questo che il genere viene proposto come violenza.

Look Wide presuppone che una società definisca specifiche norme sessuali e di genere che determinano il modo corretto di vivere.
Queste norme riguardano tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro identità o espressione sessuale e di genere. Tuttavia, coloro che non seguono la norma o che la sovvertono in forme più esplicite, trovano esclusione o possono essere potenzialmente esposti alla violenza.

Un approccio femminista alla diversità sessuale e di genere distingue cinque dimensioni che sono costruite socialmente:

Il **sesso** è considerato come l'insieme delle caratteristiche biologiche del corpo da cui gli individui sono classificati come maschi o femmine. Queste caratteristiche includono organi genitali interni ed esterni, caratteristiche sessuali secondarie, cromosomi e ormoni. Anche se il sesso è inteso come un fatto naturale, è emerso come le concezioni di genere socialmente e culturalmente costruite influenzano effettivamente la concezione binaria del sesso. Il binarismo sessuale esclude le persone intersessuali che presentano variazioni nei cromosomi, negli ormoni, nei genitali e/o nei sistemi riproduttivi.

L'**identità di genere** è un processo di auto-identificazione all'interno di un quadro normativo di ciò che significa essere un uomo o una donna. Dà significato alle nostre azioni, pensieri, sentimenti, espressioni e corpi e dice anche come "leggerli", come dobbiamo relazionarci o come dobbiamo trasformarli in risposta

all'ideale normativo. Infatti, non siamo in grado di immaginare nessuna persona senza supporre un'identità di genere. Ci dice cosa ci si aspetta da noi, quali sono i nostri limiti di azione, quali relazioni possiamo stabilire o meno.

L'**espressione di genere** è il modo in cui una persona esprime il proprio genere, che dovrebbe adattarsi all'identità di genere e al sesso.

L'**orientamento sessuale** si riferisce al desiderio sessuale di una persona. In questo ordine normativo di genere, si presume che il sesso biologico (maschio, femmina) determini una specifica identità di genere (uomo, donna) ed espressione (maschile, femminile) e un desiderio sessuale univoco (eterosessuale). In questo modo, l'eterosessualità obbligatoria appare come una componente necessaria del regime binario di genere.

Infine, la **forma di relazione** si riferisce alla disuguaglianza strutturale all'interno di questo modello binario: non solo crea due diversi tipi di persone (uomini e donne), ma produce anche una relazione asimmetrica in cui gli uomini sono posizionati sopra le donne.

La tabella seguente mostra come ognuna di queste cinque dimensioni sia connessa e come ci sia una "coerenza" prevista per tutte. Cioè, se una persona

	NORMA	ESCLUSIONE	FORMA DI CONTROLLO	LIVELLO DI OPPRESSIONE
SESSO	Maschio / Femmina	Persone inter	Intersessofobia	Binarismo sessuale
IDENTITÀ DI GENERE	Uomo / Donna	Persone trans e non binarie	Transfobia	Cisessismo
ORIENTAMENTO SESSUALE	Eterosessuale	Gay, lesbiche, bisessuali, pansessuali, asessuali/aromantici	Omofobia, lesbofobia, bifobia, panfobia e afobia	Eterosessismo
FORMA DI RELAZIONE	Superiorità degli uomini sulle donne Superiorità degli uomini cis con un'espressione di genere normata rispetto agli uomini con un'espressione di genere non normata	Donne con femminilità non normate e uomini che vengono percepiti come "l'uomo giusto"	Violenza contro le donne	Dominazione maschile

Sintesi di norme, esclusioni, forme di controllo e livelli di oppressione in relazione a genere e sessualità. La tabella è stata creata da Laura Macaya e utilizzata durante la formazione tenuta a Barcellona.

viene assegnata come maschio alla nascita, ci si aspetta che si identifichi come uomo e abbia un'espressione maschile di genere e un desiderio eterosessuale. Lo stesso accade per una persona a cui è stata assegnato il genere femminile alla nascita, che dovrebbe identificarsi come donna e avere un'espressione femminile di genere e un desiderio eterosessuale. Qualsiasi sovversione in qualsiasi dimensione si tradurrà in una punizione sociale di qualche tipo.

Tuttavia, va notato che questa tabella non raccoglie tutte le possibili forme di violenza in relazione alle norme sessuali, di genere e di sessualità (casi più specifici saranno presentati nel prossimo capitolo sulla violenza contro le persone LGBTQIA+), ma illustra che la violenza è legata al potere: risponde a una norma sociale ed è l'effetto della trasgressione di quella norma. L'unica eccezione è rappresentata dalle donne cis, che pur seguendo queste norme sono colpite dalla violenza per il fatto di essere donne.

In sintesi, l'oppressione che vivono le persone LGBTQIA+ è legata al fatto che non seguono le norme di genere e di sessualità. Le persone che sovvertono le norme di genere e di sessualità sono etichettate come diverse e designate come marginali, aggressive e persino sterminabili.

3.3 • Uno sguardo ampio alla violenza di genere

Cosa significa estendere l'attenzione sulla violenza di genere a partire da una prospettiva femminista di genere e di diversità sessuale? LOOK WIDE deve molto al progetto europeo GAP WORK che ha ispirato la concettualizzazione e la definizione di GBV. Il team partner della Catalogna ha dichiarato che la violenza di genere o la violenza eteropatriarcale possono essere intese come tutte quelle forme di violenza che hanno origine in una visione stereotipata dei generi e nelle relazioni di potere che ciò comporta (Biglia & Jiménez, 2015). Per questo motivo, la GBV nella nostra società colpisce principalmente e più fortemente i corpi delle donne, persone inter, uomini che non sono visti come " veri uomini" e persone sessualmente non normate (lesbiche, bisessuali, gay, pansessuali e altri) o con un'identità di genere non normata (trans, queer, non binaria).

La politica riguardo la GBV, sebbene con una terminologia diversa, si è concentrata sul genere come asse di oppressione. Olivella (2016) analizza i suoi principali quadri interpretativi, dando luce alla terminologia in uso e alle concettualizzazioni più comuni intorno a quella terminologia:

La **violenza domestica** si concentra sul luogo in cui la violenza avviene senza prestare attenzione al genere. Non riconosce l'esistenza del patriarcato e la violenza è vista come un problema di salute pubblica e come risultato della

dinamica interna all'unità abitativa. L'attenzione al domestico ha permesso di vedere che dietro le mura domestiche, nello spazio privato, molte donne subiscono violenze da parte dei loro partner, parenti, conoscenti, il che ha rappresentato una grande conquista del movimento femminista. Tuttavia, questo modello non riconosce le altre forme di violenza di genere che si verificano nell'unità abitativa o in altri spazi. Inoltre, non tutte le violenze che si verificano nella sfera domestica sono legate alle disparità di genere.

La **violenza contro le donne** pone l'accento sul soggetto che subisce violenza: donne e ragazze. Gli uomini sono intesi come autori della violenza mentre le donne sono viste come destinatarie passive e quasi prive di agenzia. Questa eccessiva responsabilità nei confronti delle donne può portare alla vittimizzazione. Da questa concettualizzazione la causa della violenza non è legata alla disuguaglianza di genere, ma ai valori sociali. È stato utile denunciare e ottenere il riconoscimento di questo fenomeno. Tuttavia, le radici della violenza non vengono prese in considerazione e la violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+ è invisibile.

La **violenza di genere** si concentra sulla discriminazione di genere e comprende che la violenza è un riflesso di relazioni diseguali all'interno del sistema patriarcale perpetuato dai ruoli di genere. Da questo paradigma, si presume che la GBV colpisca principalmente le donne.

La **violenza legata al genere** enfatizza la socializzazione differenziale tra uomini e donne e nelle disparità esistenti e l'importanza dei ruoli e degli stereotipi di genere, ma va oltre la violenza tra partner all'interno delle coppie eterosessuali, che è la principale forma di violenza associata alla GBV. In questo senso, diverse forme o espressioni di questa violenza sono rese visibili. Questa definizione include la violenza rivolta alle persone inter e alle persone con sessualità e identità di genere non normate che vengono discriminate a causa della loro percezione sociale di "inadeguatezza" o "trasgressione".

La definizione di violenza di genere di Look Wide è radicata nella stessa visione ampia della violenza di genere. Innanzitutto, la violenza non è vista come episodica ma normativa e funzionale. Non è vista come un problema individuale, ma un fenomeno sociale. In questo senso, una definizione politica di violenza consentirà di identificare le forme culturali e legali di violenza. In secondo luogo, comprende la violenza contro le persone inter e le persone con sessualità, identità o espressioni di genere non normate. Questa inclusione non dovrebbe oscurare la violenza contro le donne e le ragazze a causa del loro genere e come risultato della storica disparità di potere tra uomini e donne. Infine, mira a concentrarsi sulle cause strutturali e le disuguaglianze alla base della violenza come mezzo per evitare la vittimizzazione delle vittime.

ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE: "IO IN QUANTO PROFESSIONISTA"

Come professionisti nel campo del contrasto alla GBV e alla LGBTQIA+fobia, è molto comune riscontrare difficoltà nel trovare il tempo o lo spazio per riflettere sugli aspetti concettuali della nostra pratica.

L'urgenza del lavoro quotidiano fa sì che non si rifletta criticamente su tali aspetti e non permette di capire le modalità attraverso cui questi influenzano il nostro lavoro. Tuttavia, i modelli teorici che guidano la nostra prassi sono fondamentali.

Per quanto riguarda la sfida di integrare una prospettiva di genere e di diversità sessuale illustrata in questa guida, l'attività di seguito è un invito a riflettere, individualmente e/o collettivamente, sui diversi contesti concettuali utilizzati da diversi professionisti e per acquisire consapevolezza di come guidano la loro pratica. Le seguenti domande possono essere utilizzate come attività introspettiva e/o per condurre un dibattito durante una formazione o un seminario con professionisti specializzati.

Scrivi ogni domanda in un foglio A4, fai un brainstorming di due minuti su ciascuna e scrivi tutto ciò che ti viene in mente. Quindi dai un'occhiata e rifletti su ciò che hai scritto. Se stai facendo questo esercizio in gruppo, ogni persona può condividere le sue risposte con gli altri.

- *Quali sono i modelli di intervento dei diversi servizi su GBV e LGBTQIA+ nel tuo contesto?*
- *Quali sono le rigidità più impegnative delle diverse prospettive concettuali?*
- *Quali sono gli aspetti grazie ai quali poter costruire un quadro comune?*
- *Ci sono gruppi esclusi dall'accesso ai servizi? Quali misure possono essere prese per garantire l'accesso a diversi gruppi?*

3.4 • Quadro giuridico

Sebbene le condizioni politiche e giuridiche riguardanti le persone LGBTQIA+, rappresentate o concretizzate da varie leggi e linee guida, varino nei cinque paesi europei coinvolti nel progetto, ci sono anche elementi e riferimenti comuni. Tutti i paesi, ad esempio, si sono impegnati a contrastare attivamente la violenza contro i propri cittadini firmando la Convenzione di Istanbul (2014) e a livello nazionale e tutti includono la protezione delle persone LGBTQIA+ contro forme di discriminazione.

Sia a livello internazionale che nazionale, è necessario procedere a una revisione critica dei quadri giuridici esistenti. Questo capitolo intende fornire una breve panoramica delle strutture giuridiche e politiche esistenti dei partner del progetto.

3.4 • Quadro giuridico europeo sulla GBV

La violenza di genere, compresa la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica – la cosiddetta Convenzione di Istanbul – costituisce una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, come definito nella Dichiarazione e nella Piattaforma d'azione di Pechino (1995), nella Convenzione ONU sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e nel suo Protocollo Opzionale (1999), Raccomandazione Generale CEDAW n. 19 sulla violenza contro le donne e, più recentemente, nella risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale sono sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, oggi inclusi nel trattato di Lisbona:

- Articolo 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione Europea (TEU);
- Articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Sebbene limitata al lavoro, all'occupazione e alla formazione professionale, anche la Direttiva Quadro sull'Occupazione vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale (Articolo 21(1)).

La **Convenzione di Istanbul**[1] (Consiglio d'Europa, Convenzione per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica), in quanto punto di riferimento per la legislazione internazionale sulla lotta alla violenza di genere, considera la violenza di genere e la violenza contro le donne come un atto di genere che consiste in "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne".

La convenzione di Istanbul sottolinea che gli atti di violenza di genere comportano "danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche per le donne, comprese le minacce di tali atti, la privazione della libertà coercitiva o arbitraria, sia nella vita pubblica che in quella privata".

Come suggerisce il titolo della Convenzione, la GBV è trattata qui principalmente come se si trattasse di donne colpite dalla GBV (presumibilmente considerate per lo più cis e etero). Quindi, la GBV potrebbe essere vista come una forma specifica di violenza che è diretta contro una donna in quanto donna.

Anche se le statistiche mostrano che le donne sono colpite dalla GBV in modo sproporzionato, non sono l'unico gruppo sociale ad esserlo.
Inoltre, la convenzione di Istanbul non definisce chi sono le "donne".
Quelle LGBTIQA potrebbero considerarsi donne o meno, o non solamente donne. Possono anche non essere intese come categoria di donne nella Convenzione.

Per rappresentare i diritti delle persone LGBTIQA, integrando ogni forma di violenza, la categoria di persone colpite da GBV deve essere diversificata nella Convenzione di Istanbul o deve essere presa in considerazione una nuova e più ampia categoria.

Le leggi specifiche sulla GBV in Germania, Grecia, Italia, Spagna e Ungheria sono state raggruppate di seguito:

[1] La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 01/08/2014 – 10 ratifiche, di cui 8 di Stati Membri.

PAESE	LEGGE N.	ULTERIORI INFORMAZIONI
SPAGNA	1/2004 Legge organica	Misure di protezione globali contro la violenza di genere
	5/2008 Legge catalana	Diritto delle donne all'eliminazione della violenza di genere [2]
ITALIA	154/2001	Misure contro la violenza nei rapporti familiari
	38/2009	Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e lotta contro la violenza sessuale e atti persecutori
	77/2013	Ratificazione e implementazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica
	119/2013 Legge sul femminicidio	Contrasto alla violenza di genere
	Decreto legislativo 80/2015	Congedo per donne vittime di violenza di genere
UNGHERIA	Codice Penale emendato a luglio 2013	Il reato di violenza domestica (chiamato "violenza legata alle relazioni") è stato introdotto nel nuovo codice penale nel luglio 2013. La violenza domestica non è stata un "reato specifico" fino a luglio 2013.
GERMANIA	Legge AGG 2006 [3]	Legge intesa a fornire un'ampia protezione da discriminazione e da diversi tipi di disparità di trattamento (specialmente nei luoghi di lavoro, ecc.). Sebbene questa legge garantisca protezione legale contro una data discriminazione subita (d), difficilmente tutela le persone colpite da casi concreti di violenza o GBV.
GRECIA	Articoli 6, 7, 8 e 9 e 299 e 311 del Codice Penale	La "violenza domestica " è la commissione di uno dei seguenti reati contro un membro della famiglia

[2] Questa legge catalana definisce più ampiamente la VdG ,in cui vengono riconosciute diverse sfere (violenza intima del partner, ma anche violenza familiare, sul posto di lavoro e della comunità), ma si rivolge alle donne cis.

[3] Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, "Legge Generale sulla Parità di Trattamento", una legge antidiscriminatoria.

3.6 • Quadro giuridico europeo per le persone LGBTQIA+

All'interno dell'Unione Europea, i diritti delle persone LGBTQIA+ sono considerati diversamente dalle leggi dei singoli Stati sovrani. Alcuni hanno adottato una legislazione che riconosce le coppie non sposate, altri hanno riconosciuto il diritto al matrimonio omosessuale (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Islanda, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Francia, Regno Unito, Regno Unito e Irlanda) e alcuni paesi riconoscono il diritto all'adozione da parte di coppie omosessuali, anche se in varie forme.

La violenza e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQIA+ costituiscono violazioni del quadro giuridico internazionale in materia di diritti umani, che riconosce a tutte le persone i diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione. I principi fondamentali dei diritti umani sono sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri trattati internazionali sui diritti umani.
Tra gli altri:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR)

- *Articolo 2: Ogni individuo ha diritto a tutti i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status.*
- *Articolo 7: Tutti sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto ad un'uguale protezione contro qualsiasi discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.*

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

- *Articolo 2, paragrafo 1: Ogni Stato parte del presente Patto si impegna a rispettare e ad assicurare a tutti gli individui nel suo territorio e soggetti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status.*
- *Articolo 26: Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, alla pari tutela della legge. A questo proposito, la legge vieterà qualsiasi discriminazione e garantirà a tutte le*

persone una protezione uguale ed efficace contro qualsiasi discriminazione per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)

- *Articolo 2: Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti enunciati nel presente Patto saranno esercitati senza discriminazioni di alcun tipo per quanto riguarda razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status.*

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC).

- *Articolo 2: Gli Stati parti rispettano e garantiscono i diritti enunciati nella presente Convenzione ad ogni bambino nella loro giurisdizione senza discriminazioni di alcun tipo, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro tipo, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalla proprietà, dalla disabilità, dalla nascita o da altre condizioni.*

Anche gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite hanno ripetutamente affermato che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono inclusi tra i motivi di discriminazione proibiti dalla legge internazionale sui diritti umani.
Questi includono: il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Commento generale n. 18, par. 7), il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (Commento generale n. 20, par. 7), il Comitato per i diritti del bambino (Commento generale n. 4, par. 6; Commento generale n. 13, par. 60 e 72), il Comitato contro la tortura (Commento generale n. 2, par. 21), e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Raccomandazione generale n. 28, par. 18; Raccomandazione generale n. 27, par. 13).

La situazione è molto frammentata: molti paesi hanno introdotto una sorta di legislazione antidiscriminatoria; altri non hanno un quadro giuridico che vieta la discriminazione delle persone LGBTQIA+.
Pochissimi paesi hanno adottato leggi orizzontali antidiscriminazione per tutelare le persone LGBTI in tutti gli ambiti sociali [4].

[4] Legge antidiscriminazione - ILGA Europe. www.ilgaeurope.org

Nonostante il quadro giuridico europeo sui diritti LGBTQIA+, ogni paese deve valutare le disposizioni e incorporarle nel diritto nazionale.
Nel contesto europeo, e soprattutto tra i cinque paesi partner del progetto, la legge più avanzata si trova in Catalogna.

La Legge 11/2014 [5] garantisce i diritti delle persone LGBTQIA+ e mira a eliminare l'omofobia, la bifobia e la transfobia. È una legge pionieristica, perfino per il contesto europeo, che include molte delle richieste storiche dei movimenti sociali catalani di liberazione sessuale e di genere. Da un lato, il preambolo del testo giuridico afferma che lo scopo della legge sia "sviluppare e garantire i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e persone intersessuali (LGBTI) ed evitare situazioni di discriminazione e violenza, per assicurare che in Catalogna la diversità sessuale e affettiva possa essere vissuta in piena libertà".

La legge, inoltre, prevede la creazione di un servizio di supporto specifico per le persone LGBTQIA+ che hanno subito o rischiano di subire discriminazioni o violenze a causa del loro orientamento sessuale, della loro identità sessuale o di genere. L'articolo 27 è dedicato al diritto ad una protezione integrale, reale ed efficace. In particolare, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni della Catalogna devono garantire alle persone LGBTQIA+ che subiscono o rischiano di subire qualsiasi tipo di violenza o discriminazione il diritto a ricevere una protezione immediata, completa, reale ed efficace". Il diritto al sostegno e all'assistenza legale (articolo 29) stabilisce che l'amministrazione pubblica catalana "deve stabilire i meccanismi necessari per garantire che le persone LGBTQIA+ abbiano il diritto di ricevere tutte le informazioni e l'assistenza legale specializzata relative alla discriminazione e ai vari tipi di violenza esercitata contro queste persone".

Per quanto riguarda la sicurezza (articolo 18), la legge 11/2014 stabilisce diverse linee d'azione, come l'applicazione di un protocollo per il sostegno alle vittime di aggressioni LGBTQIA+fobiche e per la promozione delle denunce delle vittime.

In **Spagna** ci sono altre due leggi degne di nota: la Legge 13/2005 di modifica del Codice Civile per il diritto al matrimonio e la Legge 3/2007, che regola la rettifica di registro della menzione relativa al sesso delle persone. Tuttavia, questa seconda legge, indirizzata al collettivo trans, si limita alla regolamentazione del cambiamento di nome nella menzione del sesso nel documento d'identità, che richiede la presentazione di una diagnosi di disforia di genere e la dimostrazione di un minimo di due anni di terapia medica e considera unicamente i cittadini spagnoli adulti.

5 Sebbene applicabile solo in Catalogna, è una legge pionieristica.

In **Grecia**, esiste una legislazione limitata in materia, lasciando così le persone LGBTQIA+ senza tutela né sostegno. Alcuni diritti fondamentali sono sanciti dalla Costituzione.
Per essere più specifici: articolo 2, paragrafo 1, articoli 4, 5, 20 e 25. I suddetti articoli si riferiscono alla protezione delle persone in generale e non menzionano specificamente la comunità LGBTQIA+.

La legge 3304/2005 è la prima legge approvata specificamente contro la discriminazione, come chiarito all'articolo 2: "è vietato qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta o trattamento discriminatorio, compresa qualsiasi forma di molestia o atto offensivo per le ragioni sopra indicate". Tuttavia, le disposizioni di questa legge si limitano a proteggere le vittime di discriminazione sul luogo di lavoro. Nel contesto giuridico greco è importante citare altre due leggi: la Legge 4285/2014 per combattere alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia attraverso la legge penale e la legge 4356/2015, che stabilisce il diritto delle coppie omosessuali all'unione civile, anche se il matrimonio omosessuale non è legalmente accettabile, i rapporti tra le due parti dell'unione seguono le disposizioni della legge applicabile alle coppie sposate. Ciononostante, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è considerato legale, così come l'adozione di minori. Tuttavia, la legislazione vigente approva l'affidamento di minori da parte di coppie dello stesso sesso.
Nel maggio 2018 è stata approvata una modifica dell'articolo 8 relativo ai requisiti per diventare genitori affidatari, che consente l'affidamento, non solo ai single o alle coppie sposate, ma anche alle coppie che hanno contratto un'unione civile.

Nell'**ordinamento penale italiano**, invece la discriminazione è regolata dalla cosiddetta "Legge Mancino". Nella sua prima formulazione, la legge includeva l'orientamento sessuale, ma è stato poi eliminato dal testo nella bozza finale.

La legislazione che tutela le persone dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale si limita al campo di applicazione della direttiva europea 78/2000 (decreto legislativo n. 216/2003), che vieta la discriminazione sul lavoro per motivi di religione o credenze, disabilità, età o orientamento sessuale. Nonostante le risoluzioni del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 e del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa, che invitano tutti gli Stati membri ad agire "nella lotta contro l'omofobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e a promuovere e attuare il principio di uguaglianza nelle società e nei sistemi giuridici", in Italia sono ancora carenti leggi e politiche di uguaglianza e inclusione delle persone LGBTI. In mancanza di disposizioni specifiche che vietino la GBV contro le persone LGBTQIA+, si può fare riferimento alla legislazione incentrata sulla violenza contro le donne (GBV), indipendentemente dal sesso registrato della vittima o dell'autore del reato. Sebbene il Piano d'azione nazionale italiano sulla

violenza contro le donne sia incentrato sulla violenza perpetrata dagli uomini, il documento include la condanna e il divieto da parte dell'Italia di "qualsiasi forma di violenza di genere".

Prima della Legge 76/2016, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", la legge interna italiana non prevedeva alcuna unione alternativa al matrimonio, né per le coppie omosessuali né per quelle eterosessuali; pertanto, le prime non avevano alcun mezzo di riconoscimento. A seguito di una sentenza del 2015 (Oliari e altri contro lo Stato italiano) della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in cui la Corte ha stabilito all'unanimità che l'assenza di qualsiasi forma di riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali viola l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia è diventata il 27° paese europeo a riconoscere legalmente le coppie omosessuali.

In **Germania**, la legge generale sulla parità di trattamento garantisce pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale, vietando la discriminazione delle persone LGBTQIA+. Nell'estate del 2017, il governo federale tedesco ha ampliato il suo piano d'azione nazionale contro il razzismo, il quale vieta omofobia e transfobia. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale dall'ottobre 2017. Essendo la Germania una Repubblica Federale, molti stati hanno approvato leggi antidiscriminazione. Con la firma del Trattato di Amsterdam (UE), la Germania ha modificato le leggi nazionali antidiscriminazione includendo l'orientamento sessuale. Oggi, il matrimonio consente anche alle stesse coppie di adottare congiuntamente un figlio – mentre in precedenza solo un partner poteva adottare il figlio biologico o adottato dell'altro.

In **Ungheria** esiste una legislazione sulla parità di trattamento che vieta la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, e il codice penale fa esplicito riferimento anche ai reati di odio ("violenza contro un membro di una comunità") commessi sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Per quanto riguarda i diritti delle persone trans, in Europa c'è la possibilità di riconoscere il genere scelto in tutti gli stati ad eccezione di Albania, Kosovo, Macedonia e Cipro. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi, per accedere al cambiamento dei dati personali, è necessaria una diagnosi di disforia di genere ad eccezione di alcuni Stati come Francia, Malta, Irlanda, Belgio, Danimarca, Norvegia e Grecia.

3.7 • Progettazione di politiche pubbliche e di servizi: la necessità di ampliare

Nei casi di GBV, le persone LGBTQIA+ generalmente, non ricevono un supporto adeguato. I servizi di supporto sono rivolti principalmente alle donne etero cis colpite dalla violenza degli uomini cis. La diversità sessuale non è integrata nell'approccio lavorativo e, di conseguenza, le persone LGBTQIA+ non accedono a questi servizi o, nel caso lo facciano, è molto probabile che non ricevano servizi adeguati alle loro esigenze.

È emerso chiaramente che per poter affrontare correttamente il fenomeno della violenza di genere contro le persone LGBTQIA+, deve essere modificata un'ampia gamma di leggi. Gli articoli, i codici e i paragrafi esistenti devono essere cambiati in modo da includere tutti i casi e le identità. Le leggi "implicite", che necessitano di una giusta interpretazione da parte di un tribunale per includere adeguatamente le forme multiple di GBV, devono essere modificate per coprire esplicitamente questi casi, poiché le realtà delle persone LGBTQIA+ non sono incluse nelle leggi a contrasto della GBV. Le norme devono essere adattate e i destinatari esplicitamente indicati. Inoltre, devono essere chiaramente incaricate autorità o istituzioni che svolgano un lavoro non discriminatorio. Il lavoro di contrasto di discriminazione e violenza deve essere collettivo, retribuito e visibile. Le conseguenze della violenza di genere devono essere ampiamente note, così come le possibilità di contrastarle.

Poiché il diritto alla protezione è un diritto umano, le persone LGBTQIA+ devono essere pienamente tutelate da ciascuno Stato membro attraverso i diritti costituzionali e la loro attuazione. Pertanto, la responsabilità di garantire protezione dalla GBV alle persone LGBTI che vivono in Europa, passa dal livello europeo a quello nazionale. Ciò può portare a lunghi ritardi nei dibattiti politici, come è accaduto in Italia, dove un disegno di legge contro l'omofobia è ancora in discussione in Parlamento dal 2014, o il fatto che il Codice Penale abbia incluso l'orientamento sessuale nella sua prima formulazione ma non nella bozza finale. A tal proposito, nei casi in cui non sia chiara la responsabilità di una specifica agenzia istituzionale o di un ministero, le richieste politiche di questo tipo sono lasciate a carico, esclusivamente o quasi, di organizzazioni per i diritti umani, ONG o attivisti della comunità LGBTQIA+.

Alla luce di queste considerazioni, appare chiara la necessità di strutturare e implementare i servizi per le persone LGBTI vittime di violenza di genere. Sebbene la situazione possa variare da uno Stato all'altro, è chiaro che in nessuno dei cinque è stato ancora raggiunto un livello di protezione adeguato.

QUADRI GIURIDICI NEI DIVERSI PAESI PARTNER

Crimini e discorsi d'odio nel contesto giuridico europeo:

I crimini e i discorsi d'odio mirano a danneggiare la dignità e il valore di un essere umano appartenente a un particolare gruppo sociale in base al colore della pelle, all'etnia, alla religione/credenza, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle caratteristiche sessuali.
Su scala più ampia, trasmettono un messaggio negativo alle comunità LGBTQIA+, ai loro sostenitori e al resto della società.

Come riportato dalla Rivista annuale Rainbow Europe, per quanto riguarda i crimini e i discorsi d'odio, confrontando i cinque paesi partner, possiamo notare come l'Italia sia totalmente priva di leggi e politiche.

Anche la **Germania** è ben lontana dal pieno riconoscimento di questo fenomeno, anche se ha un piano politico di lotta all'odio (orientamento sessuale).

In **Spagna** non esiste una legge sui crimini d'odio, anche se la discriminazione in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere è considerata come un reato aggravato.
Tuttavia, in questo Paese i discorsi d'odio sono particolarmente difficili da combattere con strumenti giuridici. Infatti, con la recente riforma del codice penale, gli insulti transfobici o omofobici non sono più considerati un reato in Spagna. D'altro canto, come visto nei capitoli precedenti, la Catalogna vanta una legge d'avanguardia sull'omofobia.

In **Grecia**, invece, ci sono due leggi interessanti: 4285/2014 - articoli 1 e 4356/2015 - articolo 23 - che hanno modificato il codice penale, portando così il Paese a sviluppare politiche adeguate e raggiungendo un buon livello di protezione per le persone LGBTQIA+.

La **legge ungherese** non fa riferimento di per sé ai "crimini d'odio" o ai "discorsi d'odio". Il codice penale (artt. 216, 332), tuttavia, definisce e punisce gli atti criminali motivati da pregiudizi con esplicito riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. In relazione ai reati commessi contro persone LGBTQIA+ motivati da pregiudizio, ci sono due tipi di reati rilevanti nel diritto penale ungherese: reati sui generis, che, si riferiscono esplicitamente al pregiudizio nella definizione del motivo e dello scopo del reato;

altri reati, le cui circostanze aggravanti [6] si basano su "un movente dannoso" pur non facendo esplicitamente riferimento al pregiudizio, includendo così anche il pregiudizio basato sull'appartenenza di una persona ad un gruppo sociale.

È importante sottolineare che nessun paese partner ha adottato politiche di contrasto all'odio (intersex). A questo proposito, in Germania si discute la necessità dell'esistenza di una terza opzione di genere non binaria. Nel 2013 è stata approvata una legge controversa (PStG) che obbliga i bambini intersessuali a non avere un indicatore di genere nei loro certificati di nascita, e quindi anche nei successivi documenti di identità.
Le ONG criticano il fatto che questa lacuna nei documenti sia forzata e non facoltativa. Il diritto alla transizione verso un terzo genere non è stato legalizzato, ma recentemente un tribunale ha stabilito che anche gli adulti intersessuali possano lasciare aperto l'indicatore di genere.
Nel 2017 la Corte costituzionale federale ha stabilito che è obbligatoria una terza opzione di genere e che le leggi devono essere modificate di conseguenza fino alla fine del 2018. Attualmente in Parlamento si stanno discutendo delle modifiche legislative; particolarmente interessante sarà capire se per una tale transizione, per legge sia necessario fornire una diagnosi medica.

Importanti novità linguistiche sono state introdotte in tedesco: infatti, la Germania ha apportato le modifiche richieste dal tribunale federale.
Prima c'erano solo gli stati M e F (con i bambini inter costretti a lasciare uno spazio vuoto). Oggi, grazie alla riforma del diritto di stato civile le persone possono cambiare il loro indicatore di genere da M a F o da F a M, eliminando l'indicatore o specificandone un terzo (a per "altro".) Per ottenere questi cambiamenti, è necessaria una diagnosi che attesti una "variante di sviluppo di genere".

I policy-maker volevano una legge dedicata esclusivamente alle persone inter, ma gli attivisti hanno tentato di evitarlo, cercando una soluzione adatta a più gruppi di persone (eliminando anche la necessità di una diagnosi), ma questo tentativo è stato rifiutato dalla politica.

Le considerazioni e le analisi pubblicate, evidenziano che **il livello di protezione e prevenzione dei crimini e dei discorsi d'odio sia ancora inadeguato e frammentato**, spesso applicabile solo in alcune regioni dei paesi qui confrontati. Infatti, l'esistenza di un quadro giuridico non significa che esso venga necessariamente applicato.

[6] Una circostanza aggravante è un aspetto di un reato specificamente inclusa nella definizione del crimine nel codice penale che impone una sanzione più elevata.

CASO STUDIO DI UN MIGRANTE AL QUALE È STATO NEGATO IL DIRITTO DI ASILO

Secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGCE) del 25 gennaio 201, i richiedenti asilo nei paesi dell'Unione Europea non saranno più sottoposti a test psicologici per dimostrare la loro omosessualità.

Secondo l'ultimo rapporto ILGA "World's latest report on State Sponsorized Homophobia", 78 paesi nel mondo condannano ancora le persone sulla base del loro orientamento sessuale e cinque di questi paesi applicano la pena di morte per questo "reato". Di conseguenza, molte persone LGBTI decidono di fuggire altrove, in paesi dove i diritti umani delle persone LGBTI sono generalmente più rispettati. Alcuni scelgono di fuggire in Europa. Tuttavia, chiedere asilo in Europa può essere un processo complicato e scoraggiante. I problemi specifici delle persone LGBTI provenienti da questi paesi, non si dissolvono semplicemente attraversando le frontiere europee.

Il riconoscimento dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere come valida ragione di protezione, tuttavia, ha creato le condizioni per tutelare unicamente i richiedenti asilo LGBTQIA+, lasciando immutati alcuni problemi specifici di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali.

Il problema di fondo è che non c'è ancora sufficiente consapevolezza delle specifiche vulnerabilità dei richiedenti asilo LGBTQIA+, con conseguenze concrete nell'accoglimento delle loro richieste.

Lo stesso UNHCR ha sottolineato che i diversi gruppi LGBTQIA+ subiscono discriminazioni in modi diversi e persecuzioni diverse.
Ad esempio, le donne lesbiche sono spesso vittime di crimini d'onore e stupri punitivi; la loro situazione economica e sociale spesso influisce sul loro accesso alle procedure di asilo e la loro persecuzione è perpetrata sulla duplice base del genere e dell'orientamento sessuale.
Gli uomini gay sono più a rischio di violenza immediata e sono le prime vittime delle leggi che criminalizzano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda i bisessuali, l'orientamento sessuale è spesso erroneamente concepito come una scelta e non come un elemento di identità.
Le persone trans sono le più a rischio di emarginazione.
Infine, le persone intersessuali sono spesso percepite come disabili in relazione alla loro anatomia.

Per questi motivi, di seguito è riportato un esempio di una sentenza della Corte Europea sul ricorso di un migrante.

Nella causa *F contro il Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,*[7] **la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'illegalità dell'uso di rapporti psicologici basati su test proiettivi della personalità**[8] **per determinare l'orientamento sessuale dei richiedenti asilo**.

Il richiedente asilo, un nigeriano identificato come F, ha chiesto asilo in Ungheria, sostenendo di avere un fondato timore di persecuzione a causa della sua omosessualità. L'Ufficio Immigrazione ha respinto la sua domanda di asilo, perché sebbene avesse concluso che la richiesta di F non fosse "fondamentalmente contraddittoria", ha ritenuto che la sua dichiarazione sulla propria omosessualità "mancasse di credibilità" sulla base del rapporto di uno psicologo (paragrafo 22). F ha impugnato questa decisione dinanzi a un tribunale ungherese e il caso è stato infine deferito alla Corte di giustizia europea.

Contesto giuridico:

- *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: articolo 8, paragrafo 1*[9]
- *Diritto dell'Unione europea: Direttiva 2005/85/CE (articolo 2,4,8,8,13,39); direttiva 2011/95 (articolo 30,4,10,10,39,40); direttiva 2013/32/UE (articolo 4,10,15,46,51,52).*

Nell'aprile 2015, F ha presentato richiesta di asilo alle autorità ungheresi. A sostegno di tale richiesta, ha dichiarato, in occasione del primo colloquio condotto dall'Ufficio, di avere il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine a causa della sua omosessualità. Con decisione del 1° ottobre 2015, l'Ufficio ha respinto la richiesta di asilo di F. A tale riguardo, pur ritenendo le dichiarazioni di F fondamentalmente non contraddittorie, l'Ufficio ha tuttavia concluso che F non fosse credibile sulla base di una perizia redatta da uno psicologo. Tale perizia costituiva in un esame esplorativo, un esame della personalità e diversi test della personalità, ovvero il test chiamato "'Draw-A-Person-In-The-Rain" e i test di Rorschach e Szondi, e concludeva che non era possibile confermare l'affermazione di F relativa al suo orientamento sessuale. F ha presentato ricorso contro la decisione dell'Ufficio Immigrazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che i test psicologici cui era stato sottoposto hanno leso gravemente i suoi diritti fondamentali e non hanno consentito di valutare la credibilità del suo orientamento sessuale.

7 Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza ungherese, di seguito "Ufficio immigrazione".

8 A tale proposito, sebbene la dichiarazione di F non fosse stata ritenuta contraddittoria, si è concluso che F non fosse credibile sulla base di una perizia preparata da uno psicologo. La relazione di tale esperto ha comportato un esame esplorativo e diversi test della personalità, in particolare il test "Disegna una persona nella pioggia" e i test di Rorschach e Szondi, e ha concluso che non era possibile confermare le affermazioni di F relative al suo orientamento sessuale.

9 "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza."

4. VIOLENZA CONTRO LE PERSONE LGBTQIA+: Definizione, tipi e impatto

Il progetto Look Wide: sviluppare un metodo di lavoro a supporto delle persone LGBTQIA+ vittime di violenza di genere integrando la diversità sessuale e di genere, mira a sviluppare metodi di lavoro per fornire servizi specializzati (servizi di supporto che lavorano con persone colpite da violenza di genere) e renderli più accessibili alle persone LGBTQIA+ senza subire ulteriori discriminazioni. Tale obiettivo può essere raggiunto integrando la diversità sessuale e di genere nei metodi e negli approcci di lavoro esistenti. Questo capitolo fornisce uno schema delle manifestazioni e dei tipi di violenza che le persone LGBTQIA+ spesso affrontano nelle nostre società.

DEFINIZIONI DI VIOLENZA E VIOLENZA DI GENERE

La Violence Prevention Alliance (VPA)[10], una rete costituita da Stati membri dell'OMS, agenzie internazionali e organizzazioni della società civile che lavorano per prevenire la violenza, affronta il fenomeno della violenza come definito nella Relazione Mondiale sulla Violenza e la Salute (RMVS), ossia:

> *"l'uso intenzionale della forza o del potere fisico, minacciato o effettivo, contro se stessi, un'altra persona o contro un gruppo o una comunità, che si traduce in o ha un'alta probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, svalutazione o privazione".*[11]

Questa definizione, tuttavia, è stata criticata poiché si concentra solo su singoli atti di violenza, ignorando le forme di violenza strutturale che pervadono le nostre società e perché si focalizza esclusivamente sulla violenza fisica. Le critiche sottolineano anche che i termini e le definizioni utilizzati per descrivere la violenza di genere o legate al genere dovrebbero stigmatizzare il sessismo, il bullismo sessista o normativo, le molestie e la violenza, a prescindere da chi ne sia colpito.

La **violenza di genere** (GBV) è la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere. È un fenomeno profondamente radicato nella disuguaglianza di genere e si basa su ideologie che supportano l'idea che le donne siano subordinate agli uomini. Di conseguenza, gran parte della GBV è perpetrata in particolare contro donne e ragazze e viene spesso interpretata come "violenza contro le donne e le bambine" (VCDB). Sebbene tradizionalmente legata a quest'ultimo tipo di violenza, la GBV influenza anche le persone percepite come non conformi alle norme sessuali e di genere prevalenti.

10 http://www.who.int/violenceprevention/en/

11 http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/

Le persone LGBTQIA+ possono essere colpite da diverse manifestazioni di violenza di genere (GBV), ad es. atteggiamenti d'odioi nei confronti della loro sessualità, identità di genere o caratteristiche di genere, nonché violenza domestica o intima del partner.

4.1 • Omo-, bi- e transfobia

Comunemente i ricercatori considerano che l'omofobia, la bifobia e la transfobia siano basate su pregiudizi, incomprensioni, informazioni false, stereotipi o paure che possono avere o meno profonde giustificazioni sociali, religiose, storiche, culturali o di altro tipo. Dovremmo, tuttavia, considerare anche come le nostre società dividono le persone in gruppi (ad es. Uomini e donne, persone cis e trans) e come questi gruppi vengono quindi gerarchizzati in modo tale da privilegiare un gruppo e discriminare l'altro. La LGBTQIA+fobia è una forma di questa discriminazione. I pregiudizi e le strutture sociali del potere sono spesso acquisiti dalla propria famiglia d'origine o in altri gruppi sociali e vengono sostenuti da istituti di istruzione e politiche statali che agiscono la disuguaglianza e la disparità di trattamento delle persone LGBTQIA+.

La violenza LGBTQIA+ fobica è una violenza di genere. Simile ad altre forme di violenza di genere, si verifica a seguito di aspettative di normative di genere come visto nel capitolo precedente. Nelle società e nelle diverse comunità, esistono aspettative sociali riguardo a comportamenti o ruoli di genere accettabili e chiunque può diventare bersaglio di attacchi fisici o verbali per aver trasgredito i concetti predominanti di questi ruoli e comportamenti.
Ci sono molti esempi di trasgressione di concetti e ruoli di genere, dati dalla complessità e varietà dei ruoli sociali, di seguito elenchiamo quelli più scontati:

- I gay trasgrediscono il concetto di mascolinità se attratti sessualmente da altri uomini.
- Le donne lesbiche trasgrediscono il concetto di femminilità se attratte sessualmente da altre donne.
- Alcuni uomini e donne trasgrediscono il concetto di mascolinità / femminilità se la loro espressione di genere non corrisponde all'espressione di genere prestabilita (ad esempio se l'espressione di genere di un uomo è vista come "troppo femminile" o l'espressione di genere di una donna come "troppo maschile").
- Alcune donne trasgrediscono il concetto di femminilità perché richiedono pari trattamento rispetto agli uomini (in famiglia, sul posto di lavoro o nella vita pubblica).

- Le persone trans trasgrediscono il concetto di genere, perché superano l'idea che il genere derivi dalle proprie caratteristiche sessuali.
- Le persone trans non binarie trasgrediscono il concetto di genere perché si identificano al di fuori dei due generi culturalmente accettati (maschio e femmina).
- Le persone intersessuali trasgrediscono il concetto dei due sessi distinti e lo ricostruiscono culturalmente, attraverso i loro corpi, che non possono essere classificati né come maschi né femmine.
  (Il fatto che tutti gli organismi debbano seguire la norma culturale obbligatoria diventa visibile nel trattamento medico delle persone intersessuali.)

Il termine ha acquisito un significato ancora più ampio negli ultimi anni: la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sono anch'esse considerate forme di violenza di genere. Infatti, le vittime di violenza LGBTI sono anche vittime della violenza di genere: vengono attaccate perché non conformi alle norme di genere delle società o delle micro-comunità in cui vivono. La violenza motivata dai pregiudizi basati sull'orientamento sessuale, sull'identità o sull'espressione di genere costituisce una forma di violenza di genere, guidata dal desiderio di punire coloro che sfidano le norme di genere, in quanto non conformi a queste, destabilizzando così il sistema eterosessista prevalente.

4.2 • Crimini d'odio legati alla LGBTQIA+fobia

Per denunciare un reato come un crimine d'odio, la polizia deve essere certa che la vittima creda che il crimine denunciato sia stato commesso a causa dei pregiudizi nei confronti di un gruppo sociale. Per essere considerato un crimine d'odio da un tribunale sono necessarie due cose:

1) Elemento del reato: la prova che è stato commesso un reato, come un attacco fisico, alcune forme di violenza verbale, molestie ripetute, ecc.
2) L'elemento di pregiudizio: la prova che il reato è collegato al pregiudizio contro una caratteristica protetta (ad esempio orientamento sessuale, genere identità di genere, nazionalità, etnia, razza, religione e/o disabilità). Ciò può essere dedotto tramite parole o comportamenti agiti immediatamente prima, durante o dopo il reato, nonché da altri indicatori.

Un reato è d'odio omofobico o transfobico se il motivo dell'attacco è l'orientamento sessuale reale o percepito della vittima, l'identità di genere e/o l'espressione di genere.

Indicatori di pregiudizio

Gli indicatori di pregiudizio sono uno o più elementi che suggeriscono che un crimine potrebbe essere stato commesso per motivi di pregiudizio.
Forniscono criteri oggettivi in base ai quali giudicare il probabile motivo, ma non dimostrano necessariamente che le azioni di un autore di violenza siano state motivate da pregiudizi. Gli indicatori di pregiudizio dovrebbero essere utilizzati per decidere se indagare ulteriormente le sue opinioni e motivazioni.

Gli indicatori di pregiudizio sono molto utili a Forze dell'Ordine, Pubblici Ministeri e ONG per analizzare se un reato denunciato sia un crimine di odio.
Molti paesi e ONG hanno redatto una propria serie di indicatori.

ELENCO (NON ESAUSTIVO) DI INDICATORI DI PREGIUDIZIO

Percezione di vittima/testimone

- La vittima o i testimoni percepiscono che il crimine è stato motivato da pregiudizio?

Commenti, Dichiarazioni scritte, Gesti o Graffiti

- L'autore ha fatto commenti, dichiarazioni scritte o gesti sulla comunità della vittima?
- Sono stati realizzati disegni, simboli o graffiti sulla scena del crimine?
- Se il bersaglio è un bene inanimato, si tratta di un oggetto o un luogo con significato religioso o culturale, come un monumento storico o un cimitero?

Differenze Razziali, Etniche, di Genere e Culturali

- L'autore e la vittima differiscono in termini di razza, religione o etnia/nazionalità, orientamento sessuale/identità di genere?
- C'è un'ostilità precedente tra il gruppo della vittima e il gruppo dell'autore?
- Al momento del crimine, la vittima era impegnata in attività che promuovevano il suo gruppo?
- Il crimine si è verificato in una data di particolare significato (ad es. pride, marce,ecc.)?

Gruppi d'odio organizzati

- Sono stati lasciati oggetti o elementi sulla scena che suggeriscono che il crimine fosse opera di un'organizzazione nazionalista paramilitare o estremista?
- Esistono prove dell'attività di un gruppo di questo tipo nei dintorni? (ad es.

poster, graffiti o volantini?)

Precedenti Crimini d'odio/basati su pregiudizi

- Ci sono stati crimini simili nella stessa zona? Chi erano le vittime?
- La vittima ha ricevuto molestie per posta o telefono, o è stata vittima di abusi verbali in base alla sua affiliazione o appartenenza a un gruppo specifico?
- La vittima si trovava all'interno o in prossimità di un'area o di un luogo comunemente associati o frequentati da un determinato gruppo (ad es. un centro sociale). [12]

La violenza può essere perpetrata dallo stato (ad es. attraverso le leggi che prevedono punizioni corporali per atti omosessuali) o da individui che commettono intimidazioni, bullismo, mobbing o aggressioni. La violenza nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale percepito o della loro identità di genere può essere psicologica o fisica e può degenerare nell'omicidio. Gli Stati europei hanno smesso di sanzionare l'omosessualità solo da poco tempo, più precisamente dalla metà del XX secolo. In molti di questi stati, la violenza contro le persone LGBTQIA+ è stata classificata come crimine d'odio.

Aggressione

In gran parte dell'Unione Europea, gli atti di violenza contro un gruppo sociale sono legalmente classificati come crimini d'odio, che, in caso di condanna, comportano pene più severe. In alcuni paesi, questa forma di legislazione si estende agli abusi verbali e alla violenza fisica.

Legislazione contro i crimini d'odio omofobici e transfobici

Nel 2003, i membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno iniziato a definire i crimini d'odio basati sull'orientamento sessuale (al contrario della generica legislazione antidiscriminatoria) come circostanze aggravanti.

Tuttavia, è difficile misurare le risposte legislative delle Forze dell'Ordine a questi tipi di crimini d'odio. La scarsità di denunce e la mancanza di una raccolta coerente di dati sono fattori che ostacolano la misurazione di sviluppi concreti. Diversi gap di sistema possono essere rilevati nell'attuazione e applicazione della legge in caso di crimini di odio contro membri vulnerabili di un gruppo.

[12] Questa lista di indicatori di pregiudizio è tratta da: Understanding Hate Crimes: A Handbook for Bosnia and Herzegovina. 2010. pp. 9-10. OSCE/ODIHR https://www.osce.org/odihr/104165

Questi gap di sistema sono principalmente:

- declassificazione dei crimini d'odio,
- mancata attuazione di misure di contrasto da parte della polizia,
- mancata apertura delle indagini da parte delle autorità

Diffusione, mancanza di denunce

Esistono prove evidenti che i crimini d'odio contro le persone LGBTQIA+ persistano in tutta Europa.

Il Report LGBT 2013 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) ha rilevato che più di una persona LGBTQIA+ su quattro (26%) è stata attaccata o minacciata di violenza nei cinque anni precedenti la ricerca.
Le cifre sono ancora più allarmanti quando si tratta di persone trans, dal momento che un terzo (34%) di tutti gli intervistati trans afferma di aver subito violenza fisica o sessuale o minacce di violenza nei cinque anni precedenti l'indagine.
Le ricerche nazionali sulla vittimizzazione, nonché i casi raccolti dalle organizzazioni della società civile e segnalati all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), mostrano un elevato numero di crimini d'odio contro persone LGBTQIA+ in tutto il continente.
Il Report FRA LGBT 2013 mostra anche che in Europa la violenza omofobica e transfobica rimangono sottostimate. Vale a dire, è stato segnalato quasi un crimine su cinque (22%) riscontrato dagli intervistati nei cinque anni precedenti l'indagine.

Le forme più diffuse di crimini omofobici includono: insulti, scherno, outing forzati in pubblico, pettegolezzi, intimidazioni, isolamento, esclusione sociale, cyber bullismo, aggressioni fisiche o sessuali e minacce di morte:

- quasi il 20% di tutti gli intervistati riferisce almeno una esperienza di violenza omofobica negli ultimi tre anni precedenti alla ricerca,
- il 10% delle vittime ha subito una violenza fisica,
- quasi il 20% delle vittime è stato minacciato di violenza o di uso della forza,
- quasi il 10% delle vittime ha avuto rapporti sessuali indesiderati.

Le disuguaglianze di genere e i pregiudizi di genere sono ancora peggiori per le persone trans, che sono particolarmente a rischio di GBV perché sfidano le norme e i ruoli tradizionali di genere.

L'impatto dei crimini d'odio

Le persone vittime di crimini d'odio e violenza fisica possono sperimentare un maggiore stress psicologico rispetto alle vittime di altri crimini violenti. In particolare, le vittime di crimini motivati da pregiudizi hanno maggiori probabilità di sperimentare stress post-traumatico, problemi di sicurezza, depressione, ansia e rabbia rispetto alle vittime di crimini non motivati da pregiudizi.

I crimini d'odio inviano messaggi chiari ai membri del gruppo della vittima, ovvero di essere persone sgradite e a rischio nella società, vittimizzando l'intero gruppo e diminuendo il loro senso di sicurezza. Inoltre, assistere alla discriminazione contro il proprio gruppo può portare a disagio psicologico e perdita di autostima.

I crimini d'odio possono causare lesioni e sentimenti di malessere sia a livello individuale che comunitario. L'esperienza di un evento traumatico può infatti causare danni fisici, emotivi o psicologici, indipendentemente dal fatto che si siano verificate lesioni fisiche durante la violenza. In situazioni più gravi, può essere sviluppato un disturbo acuto da stress.

Anche se le reazioni delle vittime alle esperienze traumatiche sono individuali e quindi diverse, possono essere raggruppate in diverse categorie.
La maggior parte delle reazioni delle vittime sono combinazioni di queste categorie, secondo la classificazione di Hamer Vidmar (2016):

- Reazioni emotive – paura, vergogna, ansia, impotenza, insicurezza, tristezza, depressione, sensazione di perdere il controllo, attacchi di panico, sentirsi in colpa, sfiducia nelle altre persone, ipersensibilità, costanti cambiamenti di umore e altre intense reazioni emotive;
- Reazioni fisiche – vertigini, tremori del corpo, tensioni muscolari, disturbi psicomotori, sudorazione (in particolare sui palmi delle mani), mal di testa, elevata sensibilità all'esposizione alla luce, sensazione di freddo nella parte inferiore del corpo (in particolare nei piedi), palpitazioni cardiache, ipertensione, glicemia bassa, problemi digestivi, iperattivazione, difficoltà a parlare, difficoltà a respirare, varie fasi di shock;
- Reazioni comportamentali – reticenza: rifiuto di comunicare, isolamento, pianto, aggressività, sfoghi verbali, impazienza, abuso di droghe o alcol, autolesionismo, tentativo di suicidio;
- Reazioni cognitive – disorientamento, confusione, difficoltà di concentrazione, difficoltà a parlare, dimenticanza, distrazione.

4.3 • La violenza dello Stato conto le persone intersex

In un mondo in cui la maggioranza delle persone e dei governi conosce e accetta solo due sessi ("maschio" e "femmina") l'esistenza delle persone intersessuali e dei loro corpi non è riconosciuta. Invece, i corpi intersessuali sani sono considerati un "problema medico", un'"emergenza psicosociale"
che deve essere risolta con mezzi chirurgici, ormonali, altri mezzi medici e talvolta psicologici", scrive OII Europe nella pubblicazione *Standing up for the rights of intersex people* (ILGA Europe, 2015).

In tutta Europa, le persone intersessuali affrontano medicalizzazioni e violazioni dei loro diritti umani.

Dopo la nascita, da bambini, adolescenti e adulti, le persone intersessuali affrontano violazioni della loro integrità fisica, compresi come interventi chirurgici senza un consenso personale, preventivo, persistente e pienamente informato. Ciò può causare traumi psicologici e gravi disabilità fisiche, quali infertilità, cicatrici dolorose, perdita di sensibilità, osteoporosi, problemi uretrali.

I bambini intersessuali affrontano il rischio di una vita familiare disturbata a causa di tabù e della medicalizzazione. Sono anche a rischio di abbandono scolastico, dati gli effetti delle terapie mediche e del bullismo.

Gli adulti intersessuali possono avere difficoltà a trovare lavoro a causa di un basso livello di istruzione, disabilità fisiche o perdita di autostima causata dallo stigma sociale. È stato segnalato un rischio più elevato di povertà causata da mancata scolarizzazione, come conseguenza della patologizzazione e dei traumi che questa comporta.

Ad ogni età e in ogni momento delle loro vite, nella nostra società, le persone intersessuali rischiano di essere stigmatizzate e colpite da discriminazioni strutturali e verbali, molestie, inaccessibilità a e negazione di cure mediche adeguate, mancanza di riconoscimento giuridico e invisibilità dei propri corpi.

Pertanto, le organizzazioni intersessuali e i loro sostenitori chiedono di porre fine alle pratiche mutilanti e "normalizzanti" come interventi chirurgici genitali, trattamenti psicologici e altri trattamenti medici, attraverso mezzi legislativi o di altro tipo.

Le persone intersessuali devono avere il potere di prendere le proprie decisioni che influenzano la loro integrità corporea, autonomia fisica e autodeterminazione.

4.4 • Violenza nelle relazioni tra partner dello stesso sesso e transessuali

I movimenti femministi di tutto il mondo hanno richiamato l'attenzione sulla violenza domestica e intima, concentrandosi sulla violenza maschile contro le donne. Tuttavia, studi recenti mostrano che la violenza nelle relazioni tra partner dello stesso sesso e contro le persone trans è spesso sottovalutata dall'opinione pubblica (Viggiani, ed. 2015).
Le donne trans sono particolarmente vulnerabili e non protette all'interno delle relazioni violente, a causa di maggiori barriere economiche e sociali.

Intervistate circa le proprie relazioni, le persone LGBTI riferiscono le seguenti forme di violenza:

- gelosia e accuse varie (che spesso precedono aggressioni fisiche);
- controllo costante (via telefono o messaggi di testo);
- violenza fisica: spintona meni, percosse;
- isolamento agito dal partner (nei confronti di amici e familiari);
- ricatto (ad es. minaccia di licenziamento);
- molestie (durante la relazione o successive);
- violenza sessuale;
- dating violence (comportamento violento o minaccia di violenza all'inizio di una frequentazione);
- minaccia insistente di cambiare partner;
- reazioni violente, rottura o distruzione di oggetti.[13]

Proprio come in qualsiasi relazione, le persone che agiscono violenza controllano il comportamento del proprio partner attraverso atteggiamenti violenti o coercitivi, punendo la vittima, quando incontrano resistenze al controllo.
Chi commette violenza vuole soddisfare i propri bisogni e desideri; apprende i comportamenti violenti seguendo degli schemi e commette atti violenti solo se la punizione non è troppo dura. L'omo e la transfobia della società contribuiscono a mantenere la violenza inosservata e impunita, poiché spesso, le vittime di violenza sono isolate e non riescono a chiedere aiuto alla famiglia, ai servizi di supporto alle vittime o alle autorità giudiziarie.

13 Tratto dall'opuscolo realizzato da Háttér Society nell'ambito del progetto Bleeding Love (bleedinglove.eu): http://hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/bleedinglove-infokiadvany-0.pdf, pag. 22.

Oltre alle varie barriere strutturali, culturali, individuali e interpersonali relative ai servizi, anche i seguenti fattori risultano rilevanti per gli utenti dei servizi LGBTQIA+:

- timore di subire omofobia e transfobia nella fornitura di servizi;
- percezione e riconoscimento della violenza di genere nel contesto delle relazioni omosessuali;
- conoscenza e connessione a servizi o comunità locali LGBTQIA+;
- conoscenza, competenze e diffusione dei fornitori di servizi.

4.5 • Conclusioni: violenza contro le persone LGBTQIA+ nelle esperienze quotidiane dei Servizi

Nell'ambito del progetto, le organizzazioni partner hanno elaborato delle valutazioni dei bisogni basate sulla ricerca e le interviste con i fornitori di servizi e le persone LGBTQIA+ colpite da violenza nei rispettivi paesi.

Partendo dai risultati, è stato prodotto uno studio sulla valutazione globale dei bisogni. È emerso che i servizi segnalano un ampio spettro di violenza a tutti i livelli, che si tratti di relazioni intime o contesti familiari, nei luoghi di lavoro, a scuola, in strada o all'interno del sistema sanitario.

Coloro che si rivolgono ai servizi hanno subito numerose violazioni dei propri diritti fondamentali, in particolare le persone LGBTQIA+ transgender, intersessuali, persone di colore e/o disabili.

Molte di loro subiscono violenze quotidianamente, e hanno meno probabilità di chiedere aiuto ai servizi rispetto a molti altri gruppi. Ciò porta all'individualizzazione dei problemi: alcune conseguenze delle strutture sociali sono viste come problemi individuali (ad es. considerandoli come malattie mentali) e pertanto, rimangono invisibili ai servizi.

Esistono stereotipi che riproducono la violenza e portano alla rivittimizzazione delle persone. Per esempio, lo stereotipo relativo alle persone che si identificano come LGBTQIA+ a causa di enormi violenze subite durante l'infanzia, capovolge cause ed effetti. Molte persone LGBTQIA+ non sono sensibilizzate alla violenza, quindi solo gli episodio gravemente violenti vengono percepiti come tali.

Le persone trans sono particolarmente vulnerabili a molti tipi di violenza in numerosi scenari della loro vita quotidiana, dalla famiglia agli ambienti sociali, alle istituzioni.

MICROAGGRESSIONI

Le microaggressioni consistono in comportamenti che comunicano sottilmente o indirettamente al destinatario un messaggio dispregiativo o ostile. Avvengono quando i pregiudizi delle persone nei confronti dei gruppi emarginati (dalla negazione dell'esistenza della LGBTQIA+fobia alle ipotesi di patologie o anomalie sessuali) si rivelano, mettendo a disagio o insultando gli individui appartenenti a questi gruppi, ad es. facendo misgendering o rivolgendo domande inappropriate, intenzionalmente o per mancanza di informazioni.

Le microaggressioni fanno sentire chi le riceve socialmente a disagio, culturalmente fuori luogo, o fisicamente in pericolo.

Gran parte delle persone LGBTQIA+ subiscono microaggressioni quotidianamente, perfino quando si rivolgono ai servizi di supporto. Numerosi studi hanno dimostrato che quanto più le persone subiscono microaggressioni, tanto più manifestano sintomi quali depressione, stress e problemi di salute.

Per quanto riguarda la violenza nelle relazioni, i servizi segnalano che la violenza è agita dai partner o da altri membri della famiglia. È inoltre diffusa la minaccia di essere allontanati.

La violenza della comunità si manifesta attraverso il bullismo o le molestie, sia all'interno di contesti educativi, presso i luoghi lavoro o negli spazi pubblici: strade e servizi pubblici (alloggi compresi).

I servizi denunciano inoltre la violenza istituzionale agita direttamente contro determinate persone colpite da GBV. All'interno del sistema sanitario, le persone trans sono a rischio di violenza, in particolare, prima che sia riconosciuto legalmente il loro genere.

La violenza strutturale si manifesta spesso nel contesto della migrazione, nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati.

Quando i servizi includono i rifugiati LGBTQIA+ nella metodologia di lavoro, emergono molteplici vulnerabilità. Molte richieste di asilo sono rese invisibili o spesso prevalgono pratiche paternaliste.

I professionisti esperti di intersezionalità tra comunità LGBTQIA+ e migrazione, affermano che esista una tendenza a normalizzare la violenza associata ai processi migratori.

Le persone originarie di una cultura specifica (o percepite come tali) sono viste come "violente" o appartenenti a una cultura che normalizza la violenza.

Pertanto, gli esperti percepiscono i problemi da un punto di vista culturale e non sociale.

Le diverse comprensioni dei generi, dei ruoli di genere e i diversi livelli di accettazione, rappresentano ancora degli ostacoli all'integrazione sociale delle persone LGBTQIA+, che richiede da parte della società civile, dei governi e dei servizi, un impegno continuo e sistematico per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le persone LGBTQIA+.

IDENTIFICARE I TIPI DI VIOLENZA

I seguenti casi sono immaginari, ma basati su elementi di storie vere di persone colpite da GBV che si sono rivolte ai servizi di supporto.

Obiettivi: identificare diversi tipi di GBV contro le persone LGBTQIA+ e capire come questi si intreccino con la violenza strutturale.

Metodo: lavoro individuale o di gruppo, dibattito di gruppo

Durata: 30 minuti

Materiale (facoltativo): Schede dei casi

Descrizione dell'attività: i partecipanti leggono i casi individualmente o in gruppo, quindi il facilitatore pone domande per promuovere il dibattito.

• Caso 1 •

Sofia vive in una città da otto anni. È nata in una piccola cittadina in un'altra regione del paese e all'età di 18 anni, è andata via di casa per frequentare il college. Due anni fa ha iniziato una relazione con un'altra donna (in precedenza, aveva avuto relazioni con uomini). Le due decidono di impegnarsi in una relazione stabile. Di recente, dopo molte considerazioni, Sofia ha deciso di fare outing con i suoi genitori. Prima ne ha parlato con sua madre, che è stata comprensiva, ma anche preoccupata per la reazione di suo marito. Sofia fa outing anche con i suoi vecchi amici, senza invece riuscire a farlo con suo padre. Tuttavia sua madre insiste per parlargliene, e Sofia alla fine accetta.
Suo padre si è molto arrabbiato, dicendo di sentirsi deluso da Sofia. Continua a chiederle se qualcuno le abbia fatto del male e insiste su questa "motivazione".
Sofia si sente in colpa con la sua famiglia e inizia ad avere dubbi sulla sua relazione. A volte pensa che non ne sia valsa la pena.
Non sente la sua relazione abbastanza sicura e pensa di aver causato un conflitto inutile con la sua famiglia. Suo padre è molto turbato e le dispiace per sua madre che deve affrontare questa situazione.

• Caso 2 •

Aida e Anna stanno insieme da quattro anni. Gli amici di Anna ora diventano anche amici di Aida. Dicono di avere una relazione intensa, con molti alti e bassi. Ci sono momenti in cui entrambe si arrabbiano e si picchiano a vicenda.
Aida è messicana ed è riuscita a regolarizzare la sua situazione legale nel paese registrando la sua unione con Anna. Vive di lavori precari, anche se è un'architetta. Anna è nata in campagna e proviene da una famiglia ricca. Ha fatto coming out con la sua famiglia quando aveva 16 anni.
Anna non capisce perché Aida non dica alla sua famiglia di essere lesbica, mentre Aida ha paura di perdere il già minimo contatto che ha con i suoi genitori. Qualche mese fa, Anna ha detto ad Aida che se non avesse fatto coming out con la sua famiglia, l'avrebbe lasciata. Insinua anche che Aida non sia veramente lesbica e che si vesta in un modo molto "femminile" per nascondersi. Aida non è pronta a parlarne con i suoi genitori. La situazione tra loro è molto tesa, recentemente hanno discusso molto, Anna ha colpito Aida e ha gettato via alcune sue cose.

• Caso 3 •

Alex è un uomo trans arrivato dalla Colombia quattro anni fa. Qui, ha affrontato la transizione e per questo si sente a casa nella città in cui vive adesso. Quando ha fatto coming out a Quito, il suo paese d'origine e ha iniziato ad usare il suo nuovo nome, molte persone a lui vicine, familiari e amici, hanno smesso di parlargli. Tuttavia, continua ad avere un rapporto molto stretto con sua madre e suo fratello, si scrivono e si parlano regolarmente.
Alex ha trovato una nuova rete di amici nella sua nuova vita. La sua situazione economica, tuttavia, è instabile, quindi è costretto ad accettare lavori irregolari molto precari, principalmente lavori domestici. Per guadagnarsi da vivere, deve lavorare anche quando è malato. Inoltre, ha dovuto lasciare la stanza dove viveva in affitto e trovarne una nuova non è facile: i costi sono alti e la maggior parte delle persone non vuole condividere un appartamento con una persona trans. L'ultima volta che è andato a vedere una stanza in affitto, è stato deriso e gli affittuari gli hanno chiesto se fosse un pedofilo.

Domande per il dibattito:

- Dove si svolgono le situazioni di violenza?
- Qual è la relazione tra le persone coinvolte?
- Quali tipi di violenza riesci a identificare?
- Quali sono i fattori che hanno un impatto negativo sulla situazione di Sofia, Aida e Alex?

5. RACCOMANDAZIONI PER I PROFESSIONISTI
del contrasto alla GBV e alla discriminazione di genere

5.1 • Profili di competenze dei professionisti

I professionisti esperti nel supporto alle persone LGBTQIA+ vittime di GBV, devono essere competenti su due livelli distinti e interconnessi:

- Fornire servizi inclusivi per le persone LGBTQIA+ tenendo conto dei fattori che influiscono sul loro benessere psicofisico.
- Identificare e affrontare efficacemente i diversi tipi di violenza di genere in qualsiasi contesto, con le loro molteplici conseguenze e la necessità di servizi personalizzati.

5.1.1 • Profili di competenze dei professionisti che lavorano con le persone LGBTQIA+

Come prerequisito, i professionisti che lavorano con le persone LGBTQIA+ devono fornire uno spazio sicuro e inclusivo per qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere e stabilire un approccio intersezionale e che supporta i diritti. Devono essere a conoscenza dei diversi contesti legali, dei diritti umani nei diversi paesi e di come le esperienze di discriminazione nelle diverse culture modellino la realtà psicologica delle persone LGBTQIA+. L'orientamento sessuale e l'identità di genere possono essere le principali cause in primo piano come cause scatenanti la GBV, oppure essere fattori aggravanti della GBV. È essenziale lasciare spazio alle espressioni di queste esperienze. Alcuni principi basilari che i professionisti devono tenere a mente:

- Rispettare l'identificazione personale è fondamentale. I professionisti non devono interpretare o cercare elementi che "giustifichino" l'orientamento sessuale e /o l'identità di genere. L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere di una persona non dovrebbero essere supposti sulla base dell'aspetto o dell'espressione del genere. In generale, nessun professionista (in particolare i professionisti dei Servizi di salute mentale) può essere più consapevole dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della persona interessata. Pertanto, tentare di cambiare l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere di qualcuno è inaccettabile in ogni circostanza ed è una violazione diretta dei diritti umani. Inoltre, i professionisti non dovrebbero supporre o chiedere informazioni sull'anatomia di una persona trans (caratteristiche sessuali).

- Quando si lavora con persone LGBTQIA+, è necessario riconoscere e comprendere che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono costrutti distinti e non necessariamente connessi e bisogna essere in grado di differenziarli. Tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere sono normali e non sono malattie mentali o sintomi di una malattia mentale.[14]
  Questo vale sia per gli orientamenti omosessuali che per quelli bisessuali e per tutte le forme di identità di genere; la bisessualità o l'identificazione non binaria non è indice di ambivalenza o di una fase di transizione.
- Comprendere che il genere è un costrutto non binario che consente una serie di identità di genere e che l'identità di genere di una persona potrebbe non allinearsi al sesso assegnato alla nascita. L'identità di genere di una persona può essere inclusa o non inclusa nel genere binario. I professionisti non dovrebbero mai dare per scontato i pronomi usati e non dovrebbero usare nomi o pronomi diversi da quelli che la persona suggerisce con la propria autoidentificazione. I professionisti non dovrebbero insistere sull'uso del nome scritto nei documenti ufficiali o, il pronome – a loro avviso – più adatto.
- I professionisti non devono considerare l'esplorazione dell'orientamento sessuale o la fluidità dell'identità di genere sintomi di disturbi o indicazioni di psicopatologie. La disforia di genere non è un disturbo mentale e non deve essere considerata come un'esperienza o un'espressione comune a tutte le persone trans. I professionisti non dovrebbero in alcun caso raccomandare alle persone trans e/o intersessuali procedure mediche non necessarie alla loro salute, o non desiderate.
- Riconoscere che lo stigma, il pregiudizio, la discriminazione e la violenza influenzano la salute e il benessere psicofisico delle persone LGBTQIA+, nonché gli effetti delle barriere istituzionali (sistemiche) sulla vita delle persone LGBTQIA+.
- Creare un ambiente favorevole e positivo in cui le persone LGBTQIA+ siano in grado di esplorare il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Questo può includere provare diversi nomi, pronomi o espressioni di genere.
- I professionisti dovrebbero riconoscere i propri atteggiamenti, percezioni, pregiudizi e conoscenze e come questi influenzano la qualità dei servizi dedicati alle persone LGBTQIA+ e alle loro famiglie, richiedere consulenze e indirizzarli adeguatamente.

[14] Anche se sono presenti nei cataloghi delle malattie DSM e ICD da molto tempo o sono ancora parzialmente presenti. La disforia dell'identità di genere è presente solo nel DSM 5 e dovrebbe allinearsi all'ICD-11 nella prossima revisione, rimuovendo così l'identità di genere come malattia da tutti i sistemi di classificazione.

- Riconoscere e rispettare l'importanza delle relazioni LGBTQIA+, indipendentemente dal loro riconoscimento giuridico.
- Comprendere le reazioni della famiglia di origine circa l'orientamento lesbico, gay o bisessuale di una persona, l'identità trans o intersessuale. Ciò può avere un forte impatto sulla famiglia e sulla qualità dei rapporti, principalmente a causa della diffusa fobia LGBTQIA+.
- Riconoscere le sfide relative alle molteplici e spesso contrastanti norme, valori e convinzioni affrontate dai membri della comunità LGBTQIA+, che potrebbero anche essere membri di minoranze razziali ed etniche, nonché di altre comunità.[15]
- Considerare l'influenza della religione e della spiritualità nella vita delle persone LGBTQIA+.
- Riconoscere le problematiche e i rischi che esistono per i giovani LGBTQIA+ (ad es. la diffusione delle conseguenze del bullismo omofobo).
- Essere consapevoli e comprendere l'impatto dell'HIV/AIDS sulla vita delle persone e delle comunità LGBTQIA+ specialmente nel contesto storico dell'epidemia di AIDS degli anni '80 rispetto alle attuali conoscenze mediche e di ricerca.
- Comprendere le problematiche specifiche in ambito lavorativo per le persone LGBTQIA+, come alti tassi di disoccupazione e discriminazione sul posto di lavoro.
- Aumentare la conoscenza e la comprensione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere attraverso l'istruzione, la formazione, la supervisione e il confronto continuo.
- Riconoscere la necessità e i vantaggi di un approccio interdisciplinare nel fornire supporto alle persone TGNC (trans e di genere non conforme) e creare collaborazioni con altri esperti.
- Promuovere il cambiamento sociale al fine di ridurre gli effetti negativi dello stigma sulla salute e sul benessere degli individui trans e di genere non conforme.
- I professionisti dovrebbero riconoscere che le persone LGBTQIA+ possono condividere esperienze comuni, ma sono personalità uniche con esigenze e vite diverse. È fondamentale individuare queste differenze e i diversi modi in cui subiscono discriminazioni e stigmatizzazione.
  Ogni individuo e ogni identità rappresentata nell'acronimo (così come tutte le altre identità che non sono specificamente menzionate qui ma incluse nello spettro LGBTQIA+, come asessuale, queer, non binario, ecc.) ha esigenze distinte e diverse realtà di vita.

[15] Ci stiamo concentrando sulle minoranze razziali ed etniche perché molte discriminazioni avvengono anche per questo tipo di identità. Le persone bianche e cristiane che vivono in paesi dove le persone cristiane e bianche sono la maggioranza, potrebbero subire la LGBTIfobia, ma non in quanto cristiani bianchi.

5.1.2 • Profili di competenze dei professionisti che lavorano con le persone LGBTQIA+ colpite da GBV

La maggior parte, se non tutte, le persone LGBTQIA+ hanno subito qualche forma di violenza a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere, caratteristiche sessuali e/o espressione di genere, un tipo di violenza radicata nell'omofobia e/o nella transfobia e/o nel binarismo di genere come rappresentati in diversi contesti sociali e culturali.

Questi atti violenti, solitamente, non sono classificati come GBV, poiché l'omofobia, la bifobia, la transfobia e gli effetti negativi del binarismo di genere sono così persuasivi che la loro diffusione rimane quasi invisibile. Come nella maggior parte dei casi di discriminazione, poiché l'omofobia, la bifobia, la transfobia e il binarismo di genere non sono stati riconosciuti e identificati come tali, è difficile affrontare adeguatamente le loro espressioni più sottili e districare completamente tutti gli aspetti delle loro conseguenze. Ad esempio, le conseguenze della violenza e delle discriminazioni omofobiche, bifobiche e transfobiche comprendono, tra l'altro, traumi fisici e psicologici, ripercussioni legali e finanziarie, esclusione sociale, dissuasione accademica e professionale, ecc. In questo contesto, il forte legame esistente tra omofobia, bifobia, e/o transfobia e GBV sono rimaste a lungo inosservate, sebbene il sessismo sia il comune denominatore.

Varie forme di GBV verso persone LGBTQIA+ possono verificarsi in tutti i contesti sociali e con una vasta gamma di minacce alla qualità della vita e al benessere dei sopravvissuti. Di conseguenza, anche le esigenze di supporto e/o riabilitazione possono variare in modo significativo. Ad esempio, uno studente trans vittima di bullismo e che viene escluso a scuola in un paese occidentale e una rifugiata lesbica proveniente da un paese africano che ha subito uno stupro correttivo, sono entrambi sopravvissuti alla GBV; tuttavia le loro esigenze mediche e psicologiche e il loro accesso a servizi di supporto adeguati sono estremamente diversi.

In tutti i casi di GBV, un principio fondamentale per i professionisti del settore è il lavoro di squadra e l'approccio multidisciplinare. Lavorare con i sopravvissuti di GBV può essere estremamente difficile e pieno di sfide, pertanto è fondamentale avere un team composto da professionisti esperti in diversi campi scientifici. Lo scopo di una squadra così strutturata è duplice:

In primo luogo, per affrontare tutti gli aspetti del processo di supporto e del recupero del trauma, per aiutare i/le sopravvissuti/e a orientarsi meglio e garantire loro un sostegno adeguato alle loro esigenze (ad es. medico, psicologico, legale, psicosociale) e creare un piano di sostegno sostenibile (a breve o lungo termine, a seconda dei servizi disponibili).

In secondo luogo, il team funge da rete per tutelare tutti i professionisti coinvolti, garantendo una migliore qualità dei servizi. Un team ben funzionante è tenuto a salvaguardare i propri membri dal burnout causato dall'esposizione al trauma secondario e da tutte quelle responsabilità che vanno oltre il loro campo di competenza.

È essenziale che i professionisti che lavorano a contrasto della GBV siano formati per lavorare con persone LGBTQIA+, attraverso una formazione continua sullo stato dell'arte, dati scientifici, tutela dei diritti umani, aspetti legali all'orientamento sessuale e all'identità di genere in diversi paesi, religioni e contesti socioeconomici. Inoltre, è fondamentale che siano in contatto con le comunità LGBTQIA+ locali e che abbiano familiarità con le diverse espressioni, esperienze e sfide culturali, che possono rivelarsi contraddittorie con le proprie esperienze, ipotesi e credenze culturali. I team dovrebbero anche includere professionisti LGBTQIA+ adeguatamente formati sul contrasto alla GBV, al fine di includere le loro competenze. Infine, devono lavorare per raggiungere le comunità e gli individui creando, all'interno delle loro organizzazioni, focal point per le questioni LGBTQIA+. Questa prassi ha il valore aggiunto di facilitare il cambiamento e favorire la diversità anche nelle organizzazioni che ospitano i focal point, promuovendo la visibilità delle persone e delle questioni LGBTQIA+.

5.1.3 • Conoscenze giuridiche

Lavorare con persone LGBTQIA+ colpite da GBV può essere complicato dal punto di vista legale. Come precedentemente sottolineato, in molti paesi la legislazione in materia di GBV si riferisce alle vittime solo in quanto donne. Ad esempio, secondo l'Istituto Europeo per l'uguaglianza di Genere (dato risalente a giugno 2019), in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Irlanda lo stupro è considerato tale solo quando è commesso contro le donne. Le persone LGBTQIA+ sono spesso invisibili quando si discutono politiche e iniziative contro violenza di genere e, in molti casi, non sono protette da specifiche forme di discriminazione e violenza nelle legislazioni nazionali.

I professionisti dovrebbero inoltre avere una conoscenza approfondita di legislazione in materia di diritti, identità e protezione delle persone LGBTQIA+ e, allo stesso tempo, di legislazione in materia di GBV (come violenza nei confronti del partner, violenza domestica, stupro, violenza sessuale e molestie), ma anche di leggi sul bullismo e tutti i tipi di violenza che si basano sulla discriminazione di genere.

Di conseguenza, al fine di supportare le persone LGBTQIA+ colpite da GBV, e condurle attraverso adeguate opzioni e azioni legali, i professionisti dovrebbero avere una solida conoscenza della legislazione nazionale ed europea.

5.1.4 • Riflessione sui propri stereotipi

Tenendo conto della natura del lavoro con le persone LGBTQIA+ e dello stigma sociale che si abbatte su orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni e caratteristiche non eteronormati, diviene evidente come i professionisti siano tenuti a confrontarsi con i propri atteggiamenti e credenze per poter fornire uno spazio e un servizio sicuro, caratterizzato da inclusione ed empatia.

Al di là dei prerequisiti e delle buone intenzioni, adottare un codice etico, conoscere dati scientifici e lavorare con gli individui LGBTQIA+ significa riconoscere, lavorare e cercare di superare l'omofobia sistemica e interiorizzata, la bifobia, l'interfobia e la transfobia.

L'omofobia sistemica, la bifobia e la transfobia si traducono in stereotipi diffusi e profondamente radicati, atteggiamenti e credenze su persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali, sulle loro vite, esperienze, relazioni e realtà.

Questi stereotipi penetrano nelle menti delle persone, professionisti inclusi. Tuttavia, sono raramente riconosciuti o affrontati dai professionisti stessi e nell'educazione formale.

Riconoscere e accettare l'esistenza di questi stereotipi interiorizzati e l'impegno a creare un'atmosfera di sicurezza e fiducia è il fondamento di buone pratiche e di efficaci servizi. In molti casi, consultare un supervisore specializzato, nonché continuare un lavoro esperienziale sugli stereotipi interiorizzati, non solo è utile, ma è anche più sicuro.

Alla fine di questo capitolo, troverai due strumenti utili per farsi domande e promuovere la propria consapevolezza circa gli stereotipi.

Sono un questionario e una "fantasia guidata".
Puoi prenderti del tempo per considerare queste domande, condividerle e discuterne con colleghi e amici.

Ricorda: Essere un professionista non vuol dire avere sempre la risposta giusta, ma farsi la giusta domanda.

5.2 • Prevenzione

La GBV è una violazione dei diritti umani, ma non include solo i tipi di violenza perpetrata dagli uomini contro le donne, potrebbe anche riferirsi ad atti violenti contro uomini, ragazzi e individui LGBTQIA+, ovvero persone con identità di genere non conformi.

Il motivo per cui le persone LGBTQIA+ o quelle con espressione di genere non stereotipata, potrebbero essere vittime di GBV, è perché le loro caratteristiche sessuali corporee, l'orientamento sessuale, l'identità o l'espressione di genere mettono in discussione o confutano il ruolo dominante e stereotipato che la mascolinità esercita nella maggior parte dei contesti sociali in tutto il mondo. In altre parole, ragazzi, uomini o individui con generi non conformi, in molte occasioni corrono lo stesso pericolo delle donne - un pericolo radicato nelle stesse norme di genere, come individui che hanno meno potere nelle loro relazioni intime e nella società. Questo ovviamente, non cambia il fatto che le donne cis eterosessuali nel mondo siano maggiormente a rischio di violenza nel corso della loro vita – ma è un elemento che ci dà una percezione più completa del problema e chiarisce che la femminilità - o, per una migliore comprensione, l'assenza di mascolinità stereotipata- è un fattore chiave che aumenta l'esposizione alla violenza. A questo punto, è essenziale capire e ricordare che il "genere" è strutturato da relazioni sociali e di potere nelle quali si intrecciano religione, età, origine etnica e altre categorie sociali. Di conseguenza, non è qualcosa di statico, ma caratterizzato da fluidità e risponde ai cambiamenti che provengono dall'ambiente politico e culturale. (UNHCR, 2003). Sotto questo punto di vista, la GBV viene esercitata servendosi dei diversi tipi di norme e stereotipi derivanti dal binarismo di genere, dall'identità e/o espressione di genere, in qualsiasi aspetto sociale dell'azione umana.

Tenendo conto di ciò, diviene evidente che solo dopo aver identificato i particolari fattori di rischio per ogni tipo di GBV in ciascun ambiente, e le attività specifiche per ciascun gruppo target, è possibile elaborare strategie di prevenzione efficaci e appropriate. I possibili gruppi target sono: potenziali autori di violenza, persone colpite dalla GBV e attori coinvolti nell'identificazione e nell'accoglienza ai/alle sopravvissuti/e.

In ogni caso, le strategie di prevenzione sono più efficaci quando tutti gli attori, comprese le persone colpite da GBV, sono coinvolti nella progettazione, attuazione e valutazione delle azioni. Esistono molti fattori che possono rafforzare le strategie di prevenzione, come l'organizzazione e la ricostruzione di sistemi e servizi di supporto alle famiglie e alle comunità, la creazione o il miglioramento di procedure di monitoraggio e raccolta di episodi di GBV sulla base dell'orientamento sessuale,

identità e/o espressione di genere.

Considerato che la GBV contro le persone LGBTQIA+ è radicata nelle norme di genere, ci sono due ambiti principali su cui lavorare che possono promuovere una prevenzione approfondita e a lungo termine:

- **il miglioramento del sistema giuridico formale e tradizionale** al fine di rafforzare, proteggere e destigmatizzare le persone LGBTQIA+, promuovere la parità di diritti in qualsiasi aspetto della vita sociale, proteggere gli individui transessuali e intersessuali e garantire la loro autodeterminazione e autonomia, soprattutto nelle procedure mediche, creare un codice etico per i professionisti della salute e del sostegno psicosociale, creare leggi di tutela per combattere il bullismo omofobico, interfobico e transfobico ecc.,
- **un costante impegno nel trasformare le norme socioculturali basate su rappresentazioni patriarcali e sessiste**. Ciò potrebbe includere qualsiasi contesto sociale: sensibilizzare ambienti scolastici, accademici, professionali, servizi sanitari, famiglia e comunità contro l'omofobia, la transfobia e l'interfobia, ecc.

In qualsiasi aspetto di cui sopra, non si deve mai dimenticare che la comunità LGBTI deve rivestire un ruolo primario ed essere sempre in stretta collaborazione con le autorità decisionali.

Al fine di prevenire la GBV contro le persone LGBTQIA+ esistono strategie che possono essere implementate da uno o più gruppi/organizzazioni di professionisti, quali: campagne di informazione, istruzione, comunicazione, rafforzamento delle persone LGBTQIA+ attraverso l'ampliamento delle reti e l'aumento della rappresentanza della comunità nella leadership e nei processi decisionali, coinvolgendo anche (ma non solo) uomini eterosessuali, bambini e giovani, sensibilizzando e garantendo il rispetto dei codici di condotta e degli standard di responsabilità.

Creazione di campagne di informazione, educazione e comunicazione

Queste campagne mirano a cambiare credenze, atteggiamenti e comportamenti e possono focalizzarsi su diritti umani, inclusi i diritti LGBTQIA+, conoscenza e informazioni sulla GBV. Possono anche fornire una mappatura dei servizi disponibili. Queste campagne dovrebbero coinvolgere persone LGBTQIA+ formate e in ruoli di leadership e possono rivolgersi a gruppi particolari (ad es. scuole, istituzioni religiose, servizi sanitari) attraverso vari media (poster, opuscoli, spot televisivi, ecc.).

Rafforzare le persone LGBTQIA+ attraverso l'ampliamento di reti comunitarie e la rappresentanza nella leadership e nei processi decisionali

Le comunità LGBTI locali dovrebbero assumere un ruolo primario nelle strategie di prevenzione in tutte le fasi (progettazione, implementazione e valutazione). Gli esperti delle comunità locali dovrebbero essere individuati, assunti e formati per lavorare supportati da ONG, agenzie delle Nazioni Unite e settore pubblico. Le persone LGBTQIA+ dovrebbero partecipare al processo decisionale in tutte sue le fasi e essere formate a ricoprire ruoli di leadership.

Coinvolgere uomini eterosessuali cis, giovani e bambini

Dato che la maggior parte della violenza di genere contro le persone LGBTQIA+ è perpetrata da uomini eterosessuali cis, questi dovrebbero essere al centro di azioni e campagne specifiche, al fine di promuovere il cambiamento e agire come modelli.

Al fine di promuovere un cambiamento duraturo nelle comunità, la prevenzione dovrebbe concentrarsi su bambini e giovani attraverso i genitori e la scuola. Gli stereotipi di genere possono essere affrontati in famiglia grazie a un'adeguata formazione.

Un'eccellente esempio è la creazione nelle scuole delle *Gay Straight Alliance,*[16] che promuove l'accettazione e la protezione di studenti LGBTQIA+.

Le scuole dovrebbero riprogettare i corsi di studi e includere lezioni sui diritti umani, la salute sessuale e la consapevolezza sui ruoli di genere.

Sensibilizzazione

Le ONG e gli attori del settore pubblico dovrebbero essere formati sui diritti umani in materia di orientamento sessuale e identità di genere, legislazione nazionale e internazionale, consapevolezza di genere, omofobia, bifobia e transfobia.

Garantire il rispetto dei codici di condotta e degli standard di responsabilità

Gli operatori umanitari e gli attori del settore pubblico dovrebbero attenersi ai codici di condotta pertinenti. In caso di violazione, le sanzioni dovrebbero essere sempre applicate.

[16] Le Alleanze Gay Etero sono organizzazioni guidate da studenti o da comunità, che si trovano nelle scuole medie, superiori, college e università, degli Stati Uniti e del Canada, che intendono fornire un ambiente sicuro e di supporto per giovani, adolescenti e bambini lesbiche, gay, bisessuali e trans, nonché per i loro pari eterosessuali e cisgender.

5.3 • Individuazione, indicatori comuni e raccolta dei dati

Individuare la GBV è la prima e spesso, la parte più difficile del processo di supporto e recupero del trauma. Lo stigma che colpisce le persone LGBTQIA+ genera in esse un ulteriore carico di paura e vergogna.

Le persone LGBTQIA+ colpite da GBV possono appartenere a qualsiasi genere e fascia d'età. Indicatori noti di GBV possono essere:

- **sintomi depressivi (inclusi pensieri e / o tentativi suicidi),**
- **sintomi di ansia**
- **sintomi da stress post traumatico (ad es. Incubi, flashback, costante sensazione di ansia e stress, evitamento di stimoli che ricordano il trauma, depersonalizzazione, sensazione di alienazione)**
- **comportamenti autodistruttivi**
- **bruschi cambiamenti nei rapporti con la famiglia e gli amici**
- **abuso di sostanze, difficoltà nei rapporti personali**
- **disturbi alimentari,**
- **comportamento aggressivo,**
- **improvvise difficoltà nel rendimento scolastico,**
- **blocco della crescita (nei bambini), ecc.**

Specifici gruppi LGBTQIA+ potrebbero essere più vulnerabili alla GBV, come sex worker LGBTQIA+, rifugiati, senzatetto, persone coinvolte nel chemsex, bambini LGBTQIA+ che si affidano al sostegno degli adulti ecc.
Sebbene questo non sia un vero e proprio indicatore in sé, nella rilevazione e/o individuazione della GBV i professionisti dovrebbero considerarlo.

Il ruolo della comunità

Detto questo, diventa chiaro che il coinvolgimento della comunità è essenziale in tutte le fasi di rilevamento e individuazione della GBV tra le persone LGBTQIA+. In questo modo viene creato un doppio percorso che consente alle persone LGBTQIA+ di accedere più facilmente ai servizi di supporto e riabilitazione e viceversa. Ciò è utile anche nella raccolta e analisi dei dati, al fine di chiarire le sfide e i fattori di rischio specifici e sostenere le politiche di advocacy.

Inoltre, confrontarsi con il duplice aspetto di essere una persona LGBTQIA+ e colpita dalla GBV, può generare la paura di essere stigmatizzato dalla propria comunità, da professionisti e/o istituzioni. Una estesa e sensibile comunità può facilitare la conoscenza della GBV, destigmatizzare le persone che si trovano in queste situazioni e contribuire a creare di servizi più inclusivi e rafforzanti.

5.3.1 • Raccolta dati

Per la raccolta dei dati è essenziale utilizzare linguaggi e formulari inclusivi.

Per quanto riguarda il linguaggio, ci sono alcune regole di base:

- **Chiedi nomi e pronomi e assicurati di usare quelli indicati dalla persona interessata. NON usare nomi o pronomi diversi da quelli che la persona suggerisce con la propria autoidentificazione.**
- **NON supporre e non porre domande sull'anatomia o sulle caratteristiche sessuali di una persona.**
- **Non supporre l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere della persona in base all'apparenza o all'espressione di genere.**
- **NON interpretare la struttura e la forma delle relazioni interpersonali LGBTQIA+ secondo le norme eteronormative delle relazioni e dei ruoli eteronormativi di genere.**

Per quanto riguarda la documentazione, è importante offrire opzioni per tutti gli orientamenti sessuali, le identità di genere e i sessi assegnati alla nascita, i sessi corporei e le relazioni.

Gallop LGBTQIA+ fornisce le seguenti linee guida di esempio.

ESEMPI DI DOMANDE DEMOGRAFICHE

Come descriveresti il tuo orientamento sessuale?

- ☐ Asessuale
- ☐ Gay
- ☐ Lesbica
- ☐ Queer
- ☐ Altro (specificare)
- ☐ Bisessuale
- ☐ Eterosessuale
- ☐ Pansessuale
- ☐ Preferisco non rispondere

Come descriveresti la tua identità di genere?

- ☐ Donna (incluso donna trans)
- ☐ Preferisco non rispondere
- ☐ Uomo (incluso uomo trans man)
- ☐ Altro (specificare)

Hai mai considerato te stess* come una persona trans?

Trans è un termine generico per descrivere le persone il cui genere non è uguale al sesso assegnato alla nascita.
Le persone trans possono descrivere se stesse usando uno o più di una vasta gamma di termini, tra cui (ma non solo) transgender, transessuale, gender-queer (GQ), gender-fluid, non binario, variante di genere, crossdresser, senza genere, agender, nongender, terzo genere, bi-genere, trans uomo, trans donna, trans maschile e trans femminile.

- ☐ Sì
- ☐ Non so
- ☐ No
- ☐ Preferisco non rispondere

Ti consideri una persona con una variazione delle caratteristiche sessuali (VCS) o una persona intersessuale?

Un termine usato per descrivere una persona che può avere gli attributi biologici di entrambi i sessi o i cui attributi biologici non si adattano alle ipotesi sociali su ciò che costituisce maschio o femmina. Le persone intersessuali possono identificarsi come maschi, femmine o non binari.

- ☐ Sì
- ☐ Non so
- ☐ No
- ☐ Preferisco non rispondere

5.4 • Supportare le persone LGBTQIA+ colpite da GBV: prima accoglienza e supporto a lungo termine

Ci sono alcuni principi di base che dovrebbero essere alla base tutti i servizi forniti alle persone LGBTQIA+ colpite da GBV. Queste linee guida hanno come prerequisito una formazione professionale in grado di soddisfare le esigenze delle persone LGBTQIA+ e offrire servizi adeguati.

Riservatezza

La riservatezza assoluta deve essere assicurata, invece accade spesso che gli operatori dei servizi rivelino l'identità dei beneficiari LGBTQIA+ ai familiari o alla rete di supporto senza il loro consenso ("outing"), pensando che siano già a conoscenza di questa informazione o, soprattutto nel caso dei minori, che i loro tutori debbano essere informati per supportarli meglio.
Sebbene tale divulgazione sia mossa da buone intenzioni, costituisce una violazione della privacy e potrebbe condurre a un'ulteriore rivittimizzazione.

Evitare la ritraumatizzazione.

Chiedere troppi dettagli o informazioni sulla violenza subita, fare ipotesi o cercare di far fare outing alle persone LGBTQIA+ colpite da GBV può comportare un ulteriore trauma psicologico e un senso di esclusione. Rispettare i confini delle persone, soprattutto dopo aver subito violenza, è imperativo, al fine di evitare ulteriori traumi.

Fornitura di servizi inclusivi.

I servizi dovrebbero considerare l'intersezionalità. In molti casi, le persone colpite da GBV esprimono molteplici identità, come etnia, disabilità, stato socioeconomico, ecc. Contestualmente, i professionisti dovrebbero sforzarsi di prendere in considerazione tutti questi fattori, oltre a quelli culturali e religiosi.
Questi fattori potrebbero alterare il significato della violenza descritta o persino il significato che questa assume per il/la sopravvissuto/a.

Tutela e assistenza legale.

I servizi dovrebbero includere supporto e tutela continua delle persone colpite da GBV, specialmente se vi è un rischio elevato di reiterazione di GBV.
L'accesso all'assistenza legale dovrebbe essere facilitato, sia per la violenza già avvenuta, sia per evitare rischi futuri. I professionisti del contrasto alla GBV dovrebbero essere formati sulle problematiche LGBTQIA+,in modo da garantire la medesima qualità di servizi dei specializzati in tematiche LGBTQIA+.

Mappatura e sistema di riferimento.

Gli operatori, in particolare i primi soccorritori, dovrebbero mappare tutte le risorse i servizi disponibili in materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, tra cui ONG, centri di primo soccorso, ospedali, polizia, servizi legali.
Dovrebbero di conseguenza inviare le persone vittime di GBV a tali servizi, dopo essersi assicurati della qualità e della presenza di uno spazio sicuro e accogliente per le persone LGBTQIA+.

5.4.1 • Sostegno psico-sociale

Un sostegno psicosociale accessibile è necessario e fondamentale per le persone sopravvissute alla VdG. Come primo intervento subito dopo la violenza o come terapia a lungo termine, può aiutare la persona a elaborare il trauma psicologico. La terapia di gruppo e la partecipazione a sessioni di gruppo con altre persone LGBTQIA+ che condividono la stessa esperienza di GBV, spesso si dimostra estremamente utile e rafforzante. Nello stesso momento in cui le persone LGBTQIA+ colpite da GBV elaborano il trauma, potrebbero anche valutare di fare coming out in vari contesti, trovandosi perfino ad affrontare la propria omo/bi/transfobia interiorizzata; questa concomitanza di fattori spesso può aggravare le conseguenze della GBV.

Inoltre, i professionisti non dovrebbero mai sottovalutare la necessità di supportare, informare e educare le persone vicine (come familiari e amici) sulle conseguenze a breve e lungo termine di questo tipo violenza, dei traumi che ne derivano e altre questioni LGBTQIA+. In molte occasioni, al fine di supportare pienamente le vittime ed evitare rivittimizzazioni involontarie, i professionisti devono lavorare con la famiglia e gli amici per aiutarli a riconoscere la propria fobia nei confronti delle persone LGBTQIA+ e abbattere i propri stereotipi riguardanti sia le persone LGBTQIA+ che la violenza.

In tutte le occasioni, gli esperti e i professionisti della salute mentale che forniscono supporto psicosociale (e anche quelli medici e legali), dovrebbero seguire le linee guida di base che definiscono il codice etico e le buone pratiche nella fornitura di servizi di salute mentale alle persone LGBTI delle Nazioni Unite [17] (2015), dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ICD-11, dell'Associazione Psichiatri Americani (DSM 5, e i documenti del 2013 e 2018) e le linee guida elaborate dall'Associazione Psicologi Americani (2012 e 2015).

[17] https://www.ohchr.org/en/issues/discrimination/pages/jointlgbtistatement.aspx

5.4.2 • Denunciare

Prima di tutto, le persone colpite da GBV sono le uniche a poter decidere se denunciare e avviare procedure legali. Ciò che tutti i professionisti e i primi soccorritori dovrebbero sapere, è come fornire alle persone colpite da GBV tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole. La prima e fondamentale informazione è che la persona colpita da GBV (specialmente in caso di violenza fisica) dovrebbe essere visitata da un operatore sanitario (medico, personale sanitario, ecc.) il prima possibile dopo la violenza e richiedere che sia documentato ogni elemento. Questo è l'unico modo per garantire che si disponga di tutti i dati necessari per intraprendere successive azioni legali.

È fondamentale che il/la sopravvissuto/a si relazioni con un professionista esperto ed empatico che li accompagni attraverso questo processo, se necessario. Dopo questo primo passo, il sopravvissuto dovrebbe avere un accesso facile e aperto a tutti i tipi di supporto professionale (legale e psicosociale) per valutare tutte le opzioni disponibili e i possibili risultati di una denuncia. Al fine di garantire sostegno ed evitare la rivittimizzazione, è necessaria una stretta collaborazione tra operatori legali e psicosociali. Durante l'intero processo, è di grande importanza identificare correttamente la violenza come GBV e non come conflitto interpersonale. La GBV è una forma di violenza specifica, profondamente radicata nelle norme sociali e culturali, che enfatizza e deriva dal sessismo e dall'omofobia. Pertanto, comporta anche per la persona colpita, l'onere aggiuntivo di affrontare e subire una discriminazione strutturale.

5.4.3 • Centri antiviolenza: Accesso ed esclusione

Le persone LGBTQIA+ colpite da GBV affrontano la sfida aggiuntiva di essere spesso escluse dai Centri antiviolenza (Cav), poiché molti di questi accolgono unicamente donne cis. Ad esempio, ci sono casi noti di Cav che hanno rifiutano di accogliere uomini gay cis e sono riluttanti ad accogliere donne trans che non hanno affrontato il processo di riconoscimento giuridico del genere. Inoltre, non è prevista la presenza di persone intersessuali, non binarie, trans e di genere non conforme. La maggior parte delle operatrici che lavorano nei Centri antiviolenza hanno scarsa o nessuna esperienza di persone LGBTI colpite da GBV, così come sulle questioni e sfide specifiche che devono affrontare. Questa mancanza di conoscenza crea spesso problemi pratici che le operatrici non sono in grado di risolvere adeguatamente in modo inclusivo e non discriminatorio. Nei Centri antiviolenza, la formazione delle operatrici potrebbe rivelarsi insufficiente, poiché le donne cis traumatizzate vittime di GBV potrebbero sentirsi minacciate dalle espressioni di genere, delle persone trans, percepite come maschili (indipendentemente dall'identità di genere), il che può portare a microagressioni, discriminazione e ulteriore traumatizzazione di persone trans e con generi non

conformi. Per garantire che il Cav sia un luogo di cura per tutti, il personale deve essere adeguatamente formato ad affrontare la discriminazione. Una possibile soluzione potrebbero essere i Centri LGBTQIA+ per le vittime di GBV, dove operatori adeguatamente formati possano creare un luogo più sicuro e accogliente per le persone LGBTI colpite da GBV.

CONSIGLI PER LA CURA DI SÈ DEDICATI AGLI OPERATORI

Una questione molto importante che non va trascurata, è la cura degli operatori e la loro tutela dallo stress traumatico secondario e le sue conseguenze. Lavorare con gruppi vulnerabili, e in particolare con i sopravvissuti alla VdG, potrebbe portare a burnout, stress post traumatico, sintomi depressivi e un persistente senso di angoscia. Gli operatori dovrebbero attuare i principi di base della cura di sé, avere una supervisione regolare e creare un codice all'interno dell'organizzazione che tuteli la loro salute mentale e il loro benessere.

La rabbia costante nel lavoro, lo stress, la fatica e l'irritazione sono sintomi che non vanno mai trascurati e sono spesso correlati al lavoro di contrasto alla VdG come conseguenza dell'esposizione indiretta al trauma. Per quanto essenziale, ascoltare storie di traumi richiede anche un coinvolgimento emotivo, che a sua volta influisce negativamente sul funzionamento professionale.

In breve, ecco alcuni consigli da tenere a mente sulla cura di sé e sull'auto-osservazione:

- *Indici di trauma secondari: sbalzi d'umore improvvisi, irritabilità e aggressività (spesso con il/la sopravvissuto/a), mal di testa, ipertensione, tristezza, affaticamento, disturbi del sonno, ecc.*
- *Con che frequenza si verificano? Sono periodici o continui? (se continuo è più preoccupante)*
- *Fai attenzione al circolo vizioso che si crea tra l'ascoltare e registrare le esperienze traumatiche: negazione, sospetto, dubbio, contatto con il trauma, credere alla testimonianza, trauma secondario, senso di colpa e responsabilità, responsabilità eccessiva, distanziamento, rifiuto.*
- *Necessario: meglio fare brevi interruzioni dal lavoro e frequenti conversazioni, rispetto a interruzioni più lunghe. Le buone pratiche sono: evitare gli straordinari. Trascorrere del tempo libero. Esplorare altri argomenti e hobby. Fare vacanze regolari o weekend prolungati. Pensare al lavoro nel tempo libero potrebbe essere un segnale di avvertimento che non va ignorato.*
- *Cura di sè: Non dimenticare i tuoi passatempi preferiti, il riposo, la supervisione, il contatto con i propri cari.*

5.5 • Recupero

Il processo di recupero per tutte le vittime di GBV è complesso e di lunga durata. Come abbiamo già detto, questo potrebbe divenire ancora più difficile per le persone LGBTQIA+, perché potrebbe essere involontariamente divulgato il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere; di conseguenza, oltre agli effetti negativi del trauma, potrebbero anche subire discriminazioni dovute a omo/bi/inter/trans fobia.

Dopo un evento evento traumatico, il processo di recupero è influenzato positivamente dal senso di sicurezza, giustizia ed empowerment. Un ambiente inclusivo LGBTQIA+ e una rete di supporto che sostengano le persone colpite da GBV per esempio, a presentare una denuncia, o a eliminare il senso di colpa e di vergogna, sono sicuramente un buon inizio per il recupero. Allo stesso tempo, la riabilitazione medica ed eventualmente il recupero psico-fisico, andare di pari passo con un senso di appartenenza; le comunità LGBTQIA+ dovrebbero essere pienamente inclusive e intersezionali, così che le persone colpite da GBV, in contatto con la propria comunità, possano riprendersi più rapidamente.

ATTIVITÀ DI AUTO RIFLESSIONE:

Se hai un/a collega che non si sente a proprio agio nel lavorare con le persone LGBTQIA+, questa potrebbe essere una buona attività di riflessione per lui/lei, e per tutti i professionisti che lavorano con le persone LGBTQIA+.

Queste sono domande che vengono spesso rivolte a lesbiche, gay e bisessuali (per es. dopo aver fatto coming out). Per le persone transessuali o intersessuali le domande differiscono leggermente e ruotano attorno al genere e alle caratteristiche del sesso corporeo. Sono presenti anche diversi stereotipi relativi alle persone LGBTQIA+. Poiché tutti, crescendo, veniamo permeati da questi nemmeno le persone LGBTQIA+ ne sono totalmente prive.

Ricorda: avere questi pregiudizi, non ti rende una cattiva persona.
Scegliere di riconoscerli e lavorarci su, fa la differenza!

1. *Cosa pensi abbia causato la tua eterosessualità?*
2. *Quando e come hai deciso per la prima volta di essere eterosessuale?*
3. *È possibile che la tua eterosessualità sia solo una fase dalla quale potresti crescere?*

4. *È possibile che la tua eterosessualità derivi da una paura nevrotica verso le persone del tuo stesso sesso?*
5. *È possibile che tutto ciò di cui hai bisogno sia un/a buon/a partner gay / lesbica?*
6. *Se l'eterosessualità è normale, perché un numero sproporzionato di persone con patologie mentali è eterosessuale?*
7. *A chi hai rivelato la tua eterosessualità? Quale è stata la loro reazione?*
8. *La grande maggioranza dei molestatori di bambini sono eterosessuali (95%). Consideri davvero sicuro esporre i tuoi figli ad insegnanti eterosessuali?*
9. *Gli eterosessuali sono noti per aver assegnato a se stessi e gli altri ruoli sessuali ristretti e stereotipati. Perché ti aggrappi a una forma così malsana di giochi di ruolo?*
10. *Perché gli eterosessuali pongono così tanta enfasi sul sesso?*
11. *Sembrano esserci pochissimi eterosessuali felici. Sono state sviluppate tecniche che potresti essere in grado di utilizzare per modificare il tuo orientamento sessuale. Hai preso in considerazione la terapia dell'avversione per trattare il tuo orientamento sessuale?*
12. *Perché gli eterosessuali sono così promiscui?*
13. *Perché attribuisci l'eterosessualità ai personaggi famosi? È per giustificare la tua eterosessualità?*
14. *Se non hai mai dormito con una persona del tuo stesso sesso, come fai a sapere che non lo preferiresti?*
15. *Perché insisti a essere così scontato e fare della tua eterosessualità uno spettacolo pubblico? Non puoi semplicemente essere quello che sei e startene tranquillo?*

Tratto da Homophobia: How we all pay the price. Warren J. Blumenfeld (Ed.). 1992. Beacon Press: Boston, USA. Pages 203-204.

FANTASIA GUIDATA: "UNA PASSEGGIATA NEL PARCO"

(adattatato dal Dundalk Outcomers Facilitator Pack)

Durata: 30 minuti

Requisiti:

- Ambiente tranquillo e senza interruzioni
- Musica per preparare l'ambiente
- Mantenere il ritmo dell'esercizio lento e calmo

Scopo: A volte, anche se non ce ne rendiamo conto, viviamo secondo alcune norme che ci hanno plasmato. Con questo esercizio puoi iniziare una conversazione onesta su norme e stereotipi, riconoscendo che tutti ne abbiamo.

Procedimento della Fantasia Guidata (20 min.)

Leggi lentamente e immagina la seguente fantasia guidata.

Chiudi gli occhi. Prenditi un minuto per immaginarti in un parco pubblico. È ancora deserto. È una calda giornata estiva, i rami degli alberi sono appesantiti dalle foglie e il sole irrompe con il suo calore. C'è una leggera brezza; la senti accarezzarti il viso. Mentre guardi avanti, vedi un sentiero che si snoda in lontananza. Intorno al sentiero ci sono macchie erbose di erba tagliata e grandi alberi frondosi. L'unico suono è il canto degli uccelli. Senti gli uccelli e l'odore dell'erba appena tagliata; senti il calore del sole e la leggera brezza ti rinfresca. Guardi di fronte a te e decidi di seguire il sentiero. Inizi a camminare e ti muovi senti in lontananza voci di persone. Prima guardi a destra e poi a sinistra, noti un bambino che calcia una palla. Il bambino lancia la palla in aria e la prende mentre cade. Noti che la palla cade forte nelle mani del bambino. Due persone stanno giocando con il bambino: sorridi e saluti verso di loro notando i sorrisi sui loro volti. Continui a camminare intorno ad alcuni grandi alberi e superi due persone sedute su una panchina. Stanno ridendo forte - tu provi ad ascoltare quello che stanno dicendo. Ti muovi ancora lungo il sentiero e vedi una coppia che cammina verso di te tenendosi per mano.
Ti passano davanti mentre li guardi. Mentre cammini, alcuni uomini sono seduti su una panchina vicino al sentiero, parlano e ridono - li guardi uno per uno. Mentre cammini ti avvicini al cancello del parco, lo attraverso e davanti a te, vedi questo edificio (distinguine bene l'aspetto). Entri prima nell'edificio e poi in questa stanza. Ti siedi sulla sedia e la senti sotto di te. Inizia ad aprire lentamente gli occhi e torna nel gruppo quando sei pronto.

DOMANDE:

- *Quando hai visto il bambino con la palla, si trattava di una femmina?*
- *Le due persone che hai visto con il bambino, le hai immaginate essere i suoi genitori?*
- *Le due persone sedute sulla panchina: che aspetto avevano? Erano bianche e normodotate?*
- *La coppia che camminava verso di te tenendosi per mano; era una coppia anziana o in pensione, erano due persone normodotate, non bianche, erano due donne o due uomini?*
- *Gli uomini seduti alla panchina, erano giovani o vecchi, erano normodotati e bianchi?*
- *Qualcuno nel tuo parco indossava abiti o gioielli che ti hanno fatto pensare che provenissero da una cultura diversa dalla tua?*
- *Nel tuo parco erano tutti: - Bianchi? - Normodotati? - Giovani o di mezza età?*
- *C'erano coppie dello stesso sesso?*
- *C'erano persone anziane o pensionati nel tuo parco?*
- *C'erano diversi gruppi etnici?*
- *Perché pensi di aver visto il parco in questo modo?*
- *Come pensi possa influenzare il nostro lavoro il modo in cui vediamo il mondo?*

6. PROPOSTE PER UNA MODALITÀ DI LAVORO MULTI-AGENZIA

6.1 • Introduzione

Nel contesto della lotta contro la GBV rivolta alle donne, ci sono molte esperienze di lavoro multi-agenzia e numerosi organi e organizzazioni lo raccomandano per garantire un approccio più efficiente.

Il Consiglio d'Europa, in quanto organizzazione internazionale per il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in Europa, afferma che il lavoro multi-agenzia e i referral coordinati sono standard minimi che i servizi dovrebbero assumere per contrastare la GBV.

Poiché le persone LGBTQIA+ sono meno rappresentate dai servizi tradizionali di contrasto alla GBV, rischiando di diventare meno visibili e le loro esigenze meno comprese, il lavoro multi-agenzia è ancora più necessario. Le domande che sorgono sono, da un lato, cosa possiamo imparare dall'esperienza del lavoro multi-agenzia nel contrasto alla GBV contro donne eterosessuali cis e dall'altro, se le persone LGBTQIA+ possono essere incluse nelle reti esistenti.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota soprattutto come Convenzione di Istanbul, mira alla prevenzione della violenza, alla protezione delle vittime e cessare l'impunità degli autori di violenza.

L'articolo 7 della Convenzione di Istanbul pone la necessità di politiche globali e coordinate per prevenire e combattere tutte le forme di violenza interessate dalla Convenzione.

WAVE (2017), una rete di ONG europee di donne che lavorano nel campo della lotta alla violenza contro donne e bambini, dichiara nel Manuale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul, che gli interventi di un'unica agenzia risultano meno efficaci nel prevenire la violenza rispetto a un approccio olistico e coordinato multi-agenzia.

LOOK WIDE mira a unire le competenze nel settore LGBTQIA+ e l'esperienza del lavoro multi-agenzia nei servizi tradizionali contro la GBV.
Tuttavia, la domanda che sorge lavorando in questa direzione è: gli standard del coordinamento multi-agenzia nel contrasto alla GBV sono applicabili al contrasto alla GBV contro le persone LGBTQIA+? In tal caso, cosa possiamo imparare da queste esperienze? Quali sono le sfide che potremmo dover affrontare? E quali i cambiamenti o i miglioramenti da realizzare?

Nel rapporto comparativo transnazionale — precedentemente sintetizzato — il networking a livello locale, nazionale o internazionale, emerge come un elemento chiave per un approccio efficace e olistico alla GBV che colpisce la comunità LGBTQIA+. Il rapporto mostra la necessità di stabilire reti coordinate tra le diverse agenzie e servizi di prevenzione e contrasto alla GBV rivolti alle persone LGBTQIA+. Poiché LOOK WIDE difende un approccio femminista e di diversità di genere nei confronti della GBV, suggerisce di creare nuove reti (nei territori in cui mancano) e di coordinarsi con le reti esistenti nel campo della GBV contro le donne (che potrebbero non includere la prospettiva LGBTQIA+), lanciando la sfida di integrare una prospettiva femminista e di diversità sessuale.

Attingendo alle norme europee e ai dati qualitativi raccolti dai corsi di formazione realizzati durante il progetto LOOK WIDE, questo capitolo mira a offrire delle linee guida su come strutturare un efficiente lavoro multi-agenzia adattato alle esigenze delle persone LGBTQIA+.

6.2 • Il lavoro multi-agenzia

Il lavoro multi-agenzia si riferisce al coordinamento di diverse agenzie interessate alla stessa tematica al fine di migliorare l'efficacia complessiva del problema.

Nel campo della GBV contro le donne, un'efficace cooperazione multi-agenzia è considerata un fattore fondamentale per garantire l'assistenza alle vittime e prevenire ulteriori violenze.

A seguito della Convenzione di Istanbul, gli Stati Membri devono coordinare le misure e attuarle in cooperazione tra gli attori rilevanti. Le agenzie statali comprendono la magistratura, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, le autorità locali e regionali, nonché le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni ed entità pertinenti (articolo 18, paragrafo 2).

Il coordinamento amministrativo e la collaborazione sono fondamentali, tuttavia, le agenzie solitamente coinvolte nella lotta contro la GBV sono molto diverse e variano per dimensioni, potere, status, struttura, risorse e responsabilità: progetti peer-to-peer, centri di consulenza LGBTQIA+, organizzazioni per i diritti umani, servizi antiviolenza e antidiscriminazione gestiti dalla pubblica amministrazione o da ONG o organizzazioni senza scopo di lucro.

È essenziale essere consapevoli degli squilibri di potere tra istituzioni, agenzie e individui; inoltre dovrebbero essere prese in considerazione anche le organizzazioni di base. Diventare consapevoli di queste differenze diventa così necessario per un lavoro migliore e più efficace. In questo senso, la Convenzione di Istanbul riconosce il lavoro e la competenza delle ONG e chiede agli Stati Membri di

cooperare efficacemente con queste organizzazioni (articolo 9). In questo senso, le attività multi-agenzia di contrasto alla GBV contro le persone LGBTQIA+, devono includere le organizzazioni LGBTQIA+ e le loro preziose competenze dovrebbero essere riconosciute.

Tuttavia, la cooperazione multi-agenzia e il coordinamento dei servizi necessita non solo di riconoscere gli attori coinvolti, ma anche di stabilire protocolli e sviluppare standard di inter-agenzia, processi di intervento, processi di referral, monitoraggio e valutazione.

In sintesi, la struttura del team multi-agenzia dovrà avere chiaro:

- **Appartenenza e impegno**
- **Procedure di lavoro**
- **Ruolo di coordinamento e incarichi**
- **Presenza agli incontri multi agenzia**

6.3 • Procedure di coordinamento

Un'efficace cooperazione multi-agenzia richiede diversi livelli di coordinamento che possono comprendere una gamma eterogenea e complessa di agenti e settori. Innanzitutto, il coordinamento tra le diverse istituzioni, amministrazioni e organizzazioni viene formalizzato da protocolli e sistemi di reti di intervento. Inoltre, sono auspicabili spazi fissi di coordinamento interdisciplinare per promuovere impegno e leadership. Quindi, è molto utile delineare responsabilità, ruoli e compiti di ciascun agente e professionista della rete, tempi compresi.

Un problema che la maggior parte delle reti multi-agenzia deve affrontare è che gli operatori coinvolti sono volontari e che il loro impegno dipende principalmente dal loro interesse personale. Al fine di garantire l'impegno, la dedizione alla rete dovrebbe essere considerata e riconosciuta come parte del lavoro degli operatori coinvolti. Leadership e impegno sono un aspetto essenziale del coordinamento multi-agenzia e vanno considerati sin dall'inizio. In questo senso, per evitare una rete basata sul lavoro volontario di operatori senza potere decisionale, è necessario stabilire un organo decisionale operativo in grado di rispondere a ogni esigenza.

In ogni livello di lavoro può essere istituito un meccanismo di coordinamento. Ad esempio, le reti territoriali potrebbero essere utili in un'area specifica mentre le commissioni settoriali per tematiche o fasi specifiche del processo di intervento. Questa struttura dovrebbe essere abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun territorio.

Ai fini del nostro obiettivo vengono prese in considerazione quattro fasi di intervento nella GBV: prevenzione, individuazione, attenzione e recupero (per ulteriori informazioni, consultare il capitolo precedente di questa guida). Un team di coordinamento istituzionale dovrebbe promuovere, seguire, controllare e valutare le azioni intraprese nell'intervento globale contro la GBV.

Di seguito alcune raccomandazioni per assicurare un coordinamento efficace:

- Garantire l'accesso all'informazione inter-agenzia.
  Tutte le informazioni sulle varie risorse e servizi di una determinata area devono essere condivise tra gli operatori. Tuttavia, si deve considerare in che modo ciò influisce sulle specifiche persone supportate.
- Garantire la diffusione dei protocolli a tutti gli attori della rete.
- Stabilire meccanismi di cooperazione. I metodi di lavoro dovranno essere consentiti e condivisi da tutte le persone coinvolte nella rete.
- Imparare dalle buone pratiche locali e di contesti diversi.
- Consentire il coordinamento cooperativo tra tutti gli attori rilevanti.

6.4 • Coordinamento tra servizi

All'interno del lavoro multi-agenzia i servizi devono essere coordinati.
La Convenzione di Istanbul afferma che i servizi di supporto generico svolgono un ruolo importante nel sostenere le persone colpite da GBV e nell'indirizzarle ai servizi specializzati appropriati.

Gli operatori dei servizi generici devono disporre di risorse e formazione adeguate per sostenere le persone colpite dalla violenza e indirizzarle ai servizi appropriati: rappresentano la porta di accesso della maggior parte delle persone colpite dalla violenza.

Come mostrato da diversi studi, le donne colpite da GBV di solito contattano prima i servizi generici come l'assistenza sanitaria o sociale, piuttosto che quelli specialistici. Tuttavia, gli operatori dei servizi generici non hanno le conoscenze per individuare la violenza e prestare un'attenzione sensibile alla diversità di genere ai/alle sopravvissuti/e della violenza di genere.
Al fine di garantire un'efficace individuazione della violenza, gli operatori che lavorano nei servizi generici devono essere formati per poterla rilevare e identificare.

Nella maggior parte di questi servizi manca la prospettiva di genere e la conoscenza degli indicatori di violenza. Da un lato, i servizi non sono formati per sostenere le persone LGBTQIA+ colpite dalla GBV e per indirizzarle correttamente ai servizi specializzati. D'altro canto, i servizi specializzati tendono a coordinarsi maggiormente con servizi a loro simili, piuttosto che con servizi generali.

Al fine di ridurre questo divario, è fondamentale il coinvolgimento degli operatori dei servizi generici.

Anche effettuare appropriatamente gli invii è un elemento chiave per ridurli al minimo ed evitare vittimizzazioni secondarie. Pertanto, gli invii devono essere effettuati in modo appropriato ai servizi di supporto specialistici. Un'implementazione di successo esige invii e percorsi centrati sulla persona che siano noti a tutti gli attori coinvolti.

In sintesi, le raccomandazioni per la collaborazione tra servizi pertinenti e effettuare rinvii coordinati:

- Sviluppare strategie di individuazione specifiche e indicatori di violenza basati sulla popolazione LGBTQIA+ e condividerli correttamente con tutti i servizi.
- Garantire che i fornitori di servizi siano competenti, attenti al genere, abbiano una formazione continua e svolgano il proprio lavoro secondo linee guida, protocolli e codici etici chiari.
- Creare e implementare sistemi di rinvio basati sui diritti umani, centrati sulla persona e garantirne lo sviluppo.
- Standardizzare meccanismi e protocolli di riferimento e condividerli all'interno dei servizi.
- Concordare standard minimi per i servizi di supporto.

Di seguito sono riportate raccomandazioni specifiche:

- Solitamente, i professionisti dei servizi generici all'interno delle reti mancano di formazione sulle problematiche LGBTQIA+, quindi, in primo luogo, è essenziale formare tali professionisti nelle reti multi-agenzia esistenti. Finora, molto spesso questo impegno è dipeso dall'interesse individuale, pertanto, quando queste persone cambiano lavoro, la competenza scompare. Per evitare tale situazione, dovrebbe essere garantito un numero sufficiente di persone formate sull'argomento.

Idealmente, ogni servizio generico dovrebbe avere professionisti chiave con conoscenze a supporto delle persone LGBTQIA+ colpite da GBV.

- **Cambiare il linguaggio.** Includere la diversità è il primo passo per rendere visibili le persone LGTBI e rendere possibile il loro accesso al servizio.
- **Adattare il servizio alle esigenze delle persone LGBTQIA+.** Quello LGTBI non è un gruppo omogeneo, quindi gli operatori devono comprendere le esperienze uniche delle persone che supportano.
- **Una seria considerazione su modelli, metodi e strumenti:** la maggior parte di essi si basa su un modello eteronormativo che concentra la violenza nel quadro delle relazioni intime tra partner, in cui l'uomo perpetra la violenza e la donna la subisce.
  Questo modello non integra i servizi di supporto per gli uomini gay esposti a violenze intime da parte dei partner o le donne lesbiche che commettono questo tipo di violenza. Le persone dovrebbero ricevere supporto in merito alle loro esigenze. Inoltre, mancano adeguati strumenti di valutazione del rischio per le persone LGBTQIA+.
- **Considerare gli aspetti strutturali della GBV e della discriminazione che le persone LGBTQIA+ devono affrontare:** la femminilizzazione della povertà, il difficile accesso all'assistenza sanitaria, l'autonomia abitativa, il lavoro precario. È necessario uno sguardo integrato per considerare come tutti questi aspetti si intreccino e incidano su singoli individui. Ciò comporta l'inclusione di professionisti di diversi settori che solitamente non vengono inclusi nelle reti di contrasto alla GBV, come orientatori al lavoro e all'autonomia abitativa.

Attività di autoriflessione: ripensare la rete

Questa attività è un invito a realizzare un'analisi delle esistenti reti a contrasto della GBV. Fornisce inoltre linee guida sugli aspetti da considerare nella creazione di nuovi metodi di lavoro coordinati con una prospettiva di diversità sessuale e di genere. Supponendo che ogni contesto possa variare nel tipo di organizzazione, quadro concettuale e giuridico e politica pubblica, queste domande mirano ad iniziare una riflessione su come coordinare, con chi e ad un livello più profondo, come stabilire uno sguardo comune più ampio sulla GBV.

Attività di autoriflessione: ripensare la rete

Questa attività è un invito a realizzare un'analisi delle esistenti reti a contrasto della VdG.
Fornisce inoltre linee guida sugli aspetti da considerare nella creazione di nuovi metodi di lavoro coordinati con una prospettiva di diversità sessuale e di genere.

Supponendo che ogni contesto possa variare nel tipo di organizzazione, quadro concettuale e giuridico e politica pubblica, queste domande mirano ad iniziare una riflessione su come coordinare, con chi e ad un livello più profondo, come stabilire uno sguardo comune più ampio sulla VdG.

COSTRUIRE LA RETE	
PARTNER RILEVANTI DA INCLUDERE NELLA RETE	Quali organizzazioni lavorano nei settori della VdG in generale o dei diritti LGTBI / diversità sessuale / non discriminazione?
	Quali sono i servizi che frequentano le vittime di VdG? Sono in qualche modo coordinati? Esiste una rete esistente? Chi ne fa parte e chi no? Come possiamo creare uno spazio comune?
ANALISI DELLA RETE	Se esiste un coordinamento tra servizi e organizzazioni, quali sono i suoi punti di forza? E i suoi punti deboli? Cosa bisognerebbe migliorare?
	Se non esiste una rete, quali sfide stiamo affrontando maggiormente e quali misure possono essere prese per rispondervi?

DEFINIZIONI COMUNI	
QUADRI TEORICI E CONCETTUALI	Quali sono le definizioni di VdG dei diversi agenti della rete? Quali sono le rigidità più impegnative delle diverse prospettive concettuali e come può essere sviluppata una struttura comune?
APPROCCIO METODOLOGICO	Quali sono le visioni di lavoro dei diversi servizi della rete? Quali sono le rigidità più impegnative dei diversi modelli di intervento e come possiamo integrarli? Quali sono i background comuni/ condivisi da cui poter costruire un contesto comune?
	Ci sono gruppi esclusi dall'accesso ai servizi? Quali misure possono essere adottate per garantire l'accesso a diversi gruppi?
STANDARD MINIMI	Quali sono gli standard minimi dei servizi / della rete?
	Sono applicate le norme minime della Comunità Europea in materia di non discriminazione e approccio ai diritti umani? Gli standard applicati sono adattabili a questo approccio?

STRUTTURA	
STRUTTURA DI LAVORO CHIARA ED EFFICACE	Qual è la struttura della rete? Quali sono i compiti di ogni attore?
	Chi e come guiderà e coordinerà la rete? In base a quali standard?
	Come vengono distribuiti ruoli e compiti?
	Cosa comporta il ruolo di presidente del coordinamento?

PARTICIPAZIONE E INCLUSIONE DEI/LE SOPRAVVISSUTI/E	
EMPOWERMENT E PARTECIPAZIONE	L'empowerment delle vittime viene considerato? Come? Qual è il ruolo dei sopravvissuti?
	I sopravvissuti alla VdG sono inclusi in qualche modo nella partnership? La rete promuove la loro inclusione come esperti?
	Sono incluse le persone che affrontano discriminazioni multiple e interconnesse? Come?
	Quali sfide possono derivare da questa partnership? Come possiamo affrontarle?

DAP- LGBT DOMESTIC ABUSE PARTNERSHIP

Londra (Regno Unito)

http://lgbtdap.org.uk/

Galop è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Londra che si concentra nel sostegno alle persone lesbiche, gay, bi, trans e queer che affrontano **crimini d'odio, violenza sessuale o abusi domestici**.
Galop è il partner principale della London LGBT Domestic Abuse Partnership (DAP).

Contesto

Nel quartiere LGBTQIA+ di Londra sono pressoché assenti i servizi di contrasto alla violenza domestica e i servizi locali non sono sempre accessibili o appropriati per le vittime LGBTQIA+ e gli autori di violenza.
Esiste un numero limitato di soluzioni abitative per le persone LGBTQIA+ in fuga dalla violenza domestica e non esistono rifugi di emergenza a Londra: ciò in particolare per gli uomini gay/bi e le persone trans. Non esiste un programma per gli autori di violenza LGBTQIA+ nel Regno Unito.

Partnership

Il DAP è l'unica rete LGBTQIA+ che fornisce consulenza, e supporto alle persone LGBTQIA+ in fuga dalla violenza domestica.

La partnership è composta da cinque organizzazioni con diversi compiti e ruoli:

- Galop – assistenza sociale e supporto
- National LGBT DV helpline – sostegno telefonico/email
- London Friend – consulenza e lavoro di gruppo
- Stonewall Housing – consulenza abitativa / advocacy
- Switchboard – sostegno telefonico /consulenza 7 giorni su 7

Dal 2013 al 2017 DAP ha supportato oltre 2.300 persone LGBTQIA+ in tutti i quartieri di Londra. Il modello DAP è stato replicato in altre città del Regno Unito. DAP segnala che le donne e le ragazze sono colpite in maniera sproporzionata dalla violenza domestica e altre forme di GBV. Nel loro lavoro vengono tenute in considerazione le dinamiche di genere e sessualità. In questo senso, vengono considerati altri fattori specifici delle relazioni non eterosessuali: come ad es. essere cacciati, minacciati, ecc.. Il modello DAP deve il suo successo a diversi aspetti. In primo luogo, le persone che ricevono supporto non devono spiegare né

informare l'organizzazione circa la propria identità / situazione. In secondo luogo, le persone possono ottenere supporto senza dover contattare molte organizzazioni poiché Galop le rinvia direttamente alle organizzazioni specializzate contro la violenza domestica, su tematiche LGBTQIA+ e altri temi come immigrazione, uso di sostanze, salute mentale, ecc. Infine, la rete vanta fondi, sostegno e stima di gruppi di donne specializzate, del governo locale e centrale.

BARCELONA CIRCUIT AGAINST GENDER VIOLENCE

Barcellona (Catalogna)

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/en/preventing-and-acting/barcelona-circuit-against-gender-violence

Contesto

La legge catalana 5/2008 ha ampliato la definizione di GBV, producendo un impatto nella definizione e nella pratica dei servizi, passando dalla violenza tra partner alle diverse manifestazioni di GBV che includono il contesto familiare, la sfera del lavoro e la comunità.
Tuttavia, la violenza tra partner è già consolidata, mentre l'attenzione agli altri ambiti è ancora in fase di incorporazione nel Circuito. Inoltre, il Circuito ha iniziato a supportare le persone LGBTQIA+ colpite dalla GBV vissuta, sia violenza tra partner che di altro tipo. Questa nuova e innovativa misura dipende dalla volontà politica di intrecciare le questioni della GBV e LGBTQIA+.

Partnership

The Circuit è un progetto di collaborazione interistituzionale per il contrasto globale alla GBV. Nato nel 2001 e guidato dal Consiglio Comunale e dal Consorzio Sanitario, il suo obiettivo è promuovere un'azione coordinata tra i diversi professionisti e settori che lavorano per la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei casi di GBV in città. Sin dall'inizio, il coordinamento di programmi, servizi e risorse è stato considerato un elemento chiave per una lotta efficace contro la GBV. L'attenzione alle persone LGBTQIA+ è stata introdotta nel Circuito nel 2016. In questo momento, l'inclusione delle persone LGBTQIA+ è in un processo di definizione dei protocolli di rilevamento e supporto e dei sistemi di rinvio. Da un lato, il personale viene formato su questo tema, poiché alcuni professionisti hanno bisogno di conoscenze e competenze pratiche per affrontare questi casi. D'altro canto, è stato recentemente aperto un centro LGBTQIA+, con l'obiettivo di diventare un centro di riferimento di informazione e attenzione per la comunità LGBTQIA+.

7. CONCLUSIONI

LOOK WIDE mostra che la violenza è presente nella vita di molte persone LGBTQIA+. Negli spazi pubblici e comunitari (scuole, luoghi di lavoro, abitazioni e strade), nonché nelle loro famiglie e relazioni intime, e persino nelle istituzioni pubbliche.

Le disposizioni legislative europee e nazionali garantiscono protezione contro ogni tipo di violenza e i servizi di assistenza alle vittime operano in ciascun paese partner. Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare per garantire una protezione immediata, completa, reale ed efficace per le persone LGBTQIA+ colpite da GBV, nonché per garantire il loro diritto alle informazioni relative ai servizi di supporto.

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è stato raggiunto: sono state identificate le esigenze più urgenti di formazione dei professionisti.

Questi includono: ottenere conoscenza (di ogni lettera nell'acronimo, intersezionalità e complessità), raggiungere la visibilità (affinché le persone sappiano che possono ottenere aiuto in un determinato luogo), diffondere la pratica (sfidare il proprio pensiero normativo e le strutture all'interno del servizio, opporsi alle discriminazione presenti all'interno).

Sebbene il progetto abbia dimostrato l'importanza della formazione dei professionisti, questa da sola non è sufficiente.

Quando i servizi sono progettati in modi prestabiliti, non promuovendo la creazione di prospettive complesse, i professionisti sensibilizzati possono sentirsi frustrati nel vedere che la propria motivazione è in contraddizione con il più ampio modello di intervento o con il quadro delle politiche pubbliche.

Affinché le persone LGBTQIA+ abbiano accesso a servizi di supporto efficaci e inclusivi, la diversità sessuale e di genere deve essere parte integrante dei loro metodi e approcci di lavoro.
Tuttavia, non sono solo i metodi di lavoro a dover evolvere, ma anche le condizioni per lavorare con i sopravvissuti di GBV. Ciò di cui le persone LGBTI hanno bisogno è uguaglianza di genere e giustizia sociale, ma il nostro studio dimostra sotto numerosi aspetti, che non ne sono in possesso.

Lo stesso vale per le leggi nazionali e internazionali. Come visto in questa guida, ogni paese della nostra partnership vanta leggi diverse.

In Italia, le persone devono fare affidamento sulla costituzione per trovare protezione perché non esistono leggi effettive.

L'Ungheria ha una legge sul crimine d'odio, ma l'omo- e la transfobia non sono considerate violenza di genere.

In Catalogna esiste una legge che affronta in modo molto specifico la violenza contro le persone LGBTQIA+.

In Germania, le leggi contro la violenza possono essere interpretate in modo da includere i reati antiLGBTQIA+, ma ciò dipende ancora dagli avvocati, dal giudice e dal caso stesso. Solo quando si tratta di campi molto specifici la discriminazione è esplicitamente vietata: lavoro e alloggio.

Ma che dire di tutti gli altri ambiti della vita?
Le persone LGBTQIA+ hanno bisogno della stessa protezione, indipendentemente da dove vivono o da dove provengono. È necessario un cambiamento nelle leggi. Sono necessarie leggi migliori di quelle attualmente in vigore.

Abbiamo riscontrato enormi differenze tra i servizi di supporto a cui le persone LGBTQIA+ possono rivolgersi. Alcuni paesi forniscono servizi gestiti dallo stato, mentre in altri paesi solo le associazioni lavorano con le persone LGBTQIA+ colpite dalla violenza.
In Germania, la maggior parte dei servizi esiste perché le persone hanno creato luoghi che rispondessero alle loro esigenze. Lo stato ne finanzia alcuni, ma solo finché i politici sostengono le logiche dei servizi. Molti servizi si basano su volontari. È una situazione delicata.
Le persone LGBTQIA+ hanno bisogno di servizi di supporto validi, stabili e affidabili, che sappiano gestire i loro problemi, come per tutte le altre persone che sono o sono state colpite dalla violenza. Perché ciò accada, i servizi hanno bisogno di maggiori risorse. Dovrebbe essere impiegato più personale, soprattutto LGBTQIA+. I servizi su base volontaria devono essere finanziati e i servizi di consulenza peer-to peer devono essere sostenuti dalla politica.

La ricerca del progetto ha mostrato quanto sia necessaria e indispensabile per le vittime una varietà di servizi di consulenza (soprattutto dopo aver subito una violenza, si vuole poter scegliere dove andare e trovare sostegno adeguato alla situazione). Le persone che possono scegliere, scelgono principalmente servizi basati sulla comunità e che impiegano persone LGBTQIA+. D'altra parte, la ricerca mostra che gran parte del lavoro contro la GBV nei confronti delle persone LGTBIAQ + non è retribuito, ma volontario, specialmente nel caso di servizi peer-to-peer. Ciò è indicativo della diffusa fobia LGBTQIA+, nonché dell'emarginazione e della reticenza circa le preziose conoscenze che la comunità possiede. I professionisti LGBTQIA+ sono spesso visti "solo come LGBTQIA+", motivo per cui, il loro expertise viene ignorato e la loro professionalità non viene riconosciuta all'interno della società.

Come mostrato nella ricerca di Look Wide, avviene spesso di essere discriminati dallo stesso servizio a cui ci si rivolge; molti degli intervistati hanno parlato di questa tematica. Per questo motivo, l'integrazione della diversità di genere e sessuale nel lavoro dei servizi sociali deve essere il punto di partenza e questa guida intende essere uno strumento utile a questo scopo. Ma il lavoro continua: sono necessari servizi che lavorino con approcci intersezionali e c'è ancora molto da fare in relazione al lavoro multi-agenzia e, naturalmente, al miglioramento dei quadri politico e giuridico.

In conclusione, a livello statale:

- È necessaria una maggiore e migliore protezione legislativa per le persone LGBTQIA+
- È necessaria una protezione uguale/simile per legge in tutti i paesi dell'UE
- I bilanci nazionali devono concedere finanziamenti maggiori / migliori per i progetti e i servizi LGBTQIA+ e i servizi anti-violenza

Per quanto riguarda i servizi:

- Dovrebbe esserci più personale LGBTQIA+ nei servizi
- Dovrebbero esserci più servizi guidati da persone LGBTQIA+
- È necessario sensibilizzare tutte le persone che lavorano nel settore sociale della violenza sulle questioni LGBTQIA+
- I servizi necessitano di risorse (economiche) per i corsi di formazione
- È necessario disporre di maggiori risorse per la creazione di nuovi servizi, soprattutto quelli a livello di comunità.

RIFERIMENTI

CAPITOLO 2

Dissens
(2019).
Look Wide Transnational report.
Comparing the findings of the five partner countries.
http://lookwideproject.eu/sites/default/files/2019-03/Look%20Wide%20Comparative%20Report.pdf

CAPITOLO 3

Biglia, Barbara & Jiménez, Edurne
(2015).
Jóvenes, género y violencias: hagamos nuestra la prevención:
Guía de apoyo para la formación de profesionales.
Tarragona: URV.

Coll-Planas, Gerard & Cruells, Marta
(2013).
"La puesta en práctica de la interseccionalidad política:
el caso de las políticas LGTB en Cataluña".
Revista española de ciencia política, Núm. 31

Olivella, Maria
(2016).
Explorando las (im)posibilidades de una ley interseccional sobre violencias de género en el estado español
(doctoral dissertation).

ILGA Europe
https://www.ilga-europe.org/

Rainbow Europe
https://www.rainbow-europe.org/

EIGE- European Institute for Gender Equality
https://www.rainbow-europe.org/

ECHR- European Court of Human Rights
https://www.echr.coe.

Lesben und Schwulenverband
www.lsvd.de/politik/aktionsplaene-fuer-vielfalt-und-akzeptanz.html

Open migration
www.openmigration.org

Ghattas, Dan Christian

Standing Up for the Rights of Intersex People; How Can You Help.

ILGA-Europe - OII Europe, December 2015

Hamer Vidmar, Nikica

The Treatment of Victims of Hate Crime Against LGBTQI Persons.

Presented at the Training for the Students of the Police Academy,
May 23rd 2016, Zagreb, Croatia

OSCE/ODIHR

Understanding Hate Crimes:
A Handbook for Bosnia and Herzegovina. 2010

https://www.osce.org/odihr/104165

Viggiani, Giacomo (ed.):

Domestic and Dating Violence Against LBT Women in the EU.

Brescia, Italy, 2015

Whelan, Michael and Laura Green:

Unpacking Gender Related Violence.

Brunel University, London, 2014

American Psychiatric Association
(2013).
Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)

American Psychiatric Association
(2013).
Position Statement on Issues Related to Homosexuality.
https://www.psychiatry.org/File%20Library/About-APA/Organization-Documents-Policies/Policies/Position-2013-Homosexuality.pdf

American Psychiatric Association
(2018).
Position Statement on Discrimination Against Transgender and Gender

Diverse Individuals.
https://www.psychiatry.org/File%20Library/About-APA/Organization-Documents-Policies/Policies/Position-2018-Discrimination-Against-Transgender-and-Gender-Diverse-Individuals.pdf

American Psychological Association
(2012).
"Guidelines for Psychological Practice With Lesbian, Gay, and Bisexual Clients."
American Psychologist, Vol. 67, No. 1, 10–42
DOI: 10.1037/a0024659

American Psychological Association
(2015).
"Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People."
American Psychologist, Vol. 70, No. 9, 832–864
http://dx.doi.org/10.1037/a0039906.

DIOTIMA
(2017).
Gender Based Violence: Introductory training guide for basic terminology, principles, and approaches.

European Institution for Gender Equality.
Legal Definitions in EU Member States.
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu.

SIDA
(2015).
Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies.

UNHCR
(2003).
Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons Guidelines for Prevention and Response.

UNHCR
(2011).
Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy.

World Health Organization
(2018).
International statistical classification of diseases and related health problems
(11th Revision).
https://icd.who.int/browse11/l-m/en

Council of Europe
(2014).
The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.
https://www.refworld.org/docid/548165c94.html

WAVE - Women against Violence Europe
(2015).
Effective multi-agency cooperation for preventing and combating domestic violence.
https://www.wave-network.org/2015/09/14/effective-multi-agency-cooperation-2015/

WAVE - Women against Violence Europe
(2017).
Wave Handbook: prevention and support standards for women survivors of violence. A handbook for the implementation of the Istanbul Convention.
https://www.wave-network.org/2018/09/13/prevention-and-support-standards-for-women-and-survivors-of-violence-a-handbook-for-the-implementation-of-the-istanbul-convention-2017/


Fundació Surt
SURT
DIFFERENZA DONNA
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA
dissens
HÁTTÉR SOCIETY
KMOP
KINDLING A BETTER WORLD